# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IACE | Acemycin inj 500mg/2mL (Amikacin) | EXT;IH;IM;INS; IVD;IVI;SCI; SUBCI; | | 【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【D5NS】可選 。【H/S】可選 。 | | 成人:每500 mg 滴注時間大於 30 ~ 60 分鐘。Infant:滴注時間應大於1 ~ 2 小時。Pediatrics: 滴注時間應大於30 ~ 60 分鐘。 | 1. 監測體溫、CBC、腎功能、聽覺功能。2. 建議監測藥物血中濃度。 |
| IACET | Acetamol inj 1gm (Propacetamol) | IVD;IVPUSH; | 請使用廠商所附之專用稀釋液(5mL)。 | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | IVPUSH: 成人靜脈注射以 20mL N/S稀釋，使滲透壓約為 400 mOsm/L。可兩分鐘內直接注射。(緩慢推注避免注射時疼痛) | IVD: 成人建議將藥物加入 125mL N/S後15分鐘內輸注完畢。四歲以上(或體重17kg以上)孩童建議先加入D5W或N/S，再以每公斤體重每次注射1-2mL，於平均為時15分鐘的時間靜脈輸注。(輸注完應以10mL N/S沖管路) | 1.廠商建議避免IVPUSH方式給藥避免注射部位疼痛。(20211123諮詢藥廠) 2.本藥須使用廠商提供之稀釋液溶解。3.本品開瓶後應一次使用完畢，不得分次注射。4.本品調配後須於30分鐘內使用，不可與其他藥物混合使用。5.病人可以口服時應盡快改用口服Acetaminophen。6.對Acetaminophen過敏者禁用。7.特殊族群:肝、腎功能受損者需調整劑量。 |
| IACL | Aclasta inj 5mg/100mL (Zoledronic Acid) | IVD; | | | | 輸注時間 > 15 分鐘(輸注完應以10mL N/S沖管路) | 1.注射液不可接觸含有鈣離子或其他二價離子的溶液(例如:lactated Ringer)，必須以單獨的輸注管路給藥。2.若藥品已冷藏，輸注前先讓注射溶液回復到室溫。開瓶後的溶液在攝氏2-8度下可保存24小時。3.病人接受Aclasta輸注前，必須保持水分充足的狀態(adequately hydrated)。 |
| IACT | Actilyse inj 50mg (Human Plasminogen Activator) | IVD; | 使用所附稀釋溶液(50mL)調配好的Actilyse 1 mg/mL | 【N/S】可選 。 | X | Acute ischaemic stroke: 0.9 mg/kg via infusion over 60 min. MI: 15 mg as bolus，then 50 mg (0.75 mg/kg in patients <65 kg) via infusion over 30 min，followed by 35 mg (0.5 mg/kg in patients <65 kg) via infusion over 1 hr. Max total: 100mg. | 1. 使用所附稀釋溶液(50mL)調配好的Actilyse 1 mg/mL，可用N/S進一步稀釋，最低濃度 0.2 mg/mL。不可使用其他輸注液稀釋，也不可與其他藥物混合。2. 注射速率依照醫囑指示，不同適應症有不同的給藥時程表。 |
| IACTMV | Actemra Infusion 80mg/4mL/Vial (限Covid-19) (Tocilizumab) | IVD; | | 【H/S】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | 體重低於30公斤:以50mL 0.9%或0.45%氯化鈉注射液稀釋。體重達30公斤以上:以100mL 0.9%或0.45%氯化鈉注射液稀釋。稀釋時請輕輕倒置混合藥液，避免產生泡沫。輸注時間應超過60分鐘 | 1.本藥以0.9%氯化鈉注射液稀釋後置於2-8°C或室溫可保存24小時。以0.45%氯化鈉注射液稀釋後置於2-8°C可保存24小時或室溫可保存4小時。儲存時應避光。2.單次靜脈點滴給藥時間應超過60分鐘以上。不可靜脈推注(bolus or push)。3.不可與其他藥物共用靜脈輸注管線。 |
| IACTMV10 | Actemra Infusion 200mg/10mL/Vial(限Covid-19) (Tocilizumab) | IVD; | | 【H/S】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | 體重低於30公斤:以50mL 0.9%或0.45%氯化鈉注射液稀釋。體重達30公斤以上:以100mL 0.9%或0.45%氯化鈉注射液稀釋。稀釋時請輕輕倒置混合藥液，避免產生泡沫。輸注時間應超過60分鐘 | 1.本藥以0.9%氯化鈉注射液稀釋後置於2-8°C或室溫可保存24小時。以0.45%氯化鈉注射液稀釋後置於2-8°C可保存24小時或室溫可保存4小時。儲存時應避光。2.單次靜脈點滴給藥時間應超過60分鐘以上。不可靜脈推注(bolus or push)。3.不可與其他藥物共用靜脈輸注管線。 |
| IADE | Adenocor inj 6mg/2mL (Adenosine) | IA;IVP;IVPUSH; | | | 快速靜脈注射 (over 1 to 2 seconds)。 | | 1.本藥品對年長者較具感受性。 |
| IADR1 | Adrenalin inj 1mg/mL (Epinephrine) | EXT;IH;IM;IRR; IVD;IVPUSH;LI; SC; | | 【D5NS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【L/R】可選 。 | IV push for cardiac resuscitation management. | IVD: 1-15 mcg/min | 1. 治療Anaphylaxis反應: 0.2 to 0.5 mg IM 或 SC，可視情況每 5 分鐘投予。2. 治療Anaphylaxis反應: : (IV infusion) 稀釋1 mg in 250 mL D5W (4 mcg/mL)，給藥速率 1 mcg/min (15 mL/hr) 至 10 mcg/min，或稀釋為 1 mg in 100 mL NS (10 mcg/mL)，給藥速率 5 to 15 mcg/min (30 to 100 mL/hr)。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAGG | Aggrastat inj 12.5 mg/50mL (Tirofiban) | IVD; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | Maintenance infusion: 0.1-0.15 mcg/kg/minute according to indication. | 1.使用前須稀釋不可使用原液，稀釋方法取250mL注射用N/S或D5W抽掉50mL丟棄。加入50mL藥液稀釋於200mL溶液，使最終濃度為50 mcg/mL。2.依體重調整適合劑量投與藥品。3.本藥不可與diazepam 使用同一支靜脈輸注管。4.避光儲存 |
| IALBU20 | Alburx inj 20% 50mL (Albumin) | IVD; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | 靜脈輸注速率不超過1-2 mL/minute | 1.每毫升溶液含有約3.2毫克的鈉(140 mmol/L)。用於需要限制鈉攝取量的病人時應注意。2.本品可直接施打，也可用等滲壓溶液進行稀釋（如5%葡萄糖或0.9%氯化鈉）至比正常血漿輕微低張的溶液(4–5% 白蛋白)，比例為 1 毫升第二代"國血製劑益康"人類血清白蛋白20%注射液搭配 4 毫升適當的晶體溶液。禁止使用注射用水稀釋。3.不可與任何其他藥品混合，包括全血、紅血球濃縮液或其他白蛋白。4.輸注速率應根據個人的情況和徵兆調整，但是一般應不超過1-2毫升/分鐘。5.若大量施用，本製品應在使用前加熱至室溫或體溫。若溶液曾經冷凍，請勿使用。 |
| IALF1 | Alfentanil inj 1mg/2mL (Alfentanil) | IVD;IVPUSH; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | Administered over 3 minutes. | 中長時間的手術：藥物的初次劑量與手術預期時間的配合如下：手術時間(分鐘) Alfentanil (micrograms/kg) 靜脈注射一次給藥劑量 (mL/70kg) 10-30 20~40 3-6 30-60 40~80 6-12 > 60 80~150 12-20 | 廠商提供的安定性試驗 1支稀釋於500mL的注射用生理食鹽水或5%葡萄糖水中可保持24小時安定。[Micromedex 20220526] Recommended concentration was diluted to 25 to 80 mcg/mL. [Micromedex 20220526] Induction dosage: 8 to 20 mcg/kg IV administered over 3 minutes. |
| IALI1 | Alimta inj 100mg (小劑量) (Pemetrexed) | IVD; | | | | | |
| IALY | Alymsys inj 100mg/4mL (Bevacizumab) | IVD; | | 【N/S】可選 仿單建議。 | | 第一次使用，輸注時間為90 分鐘。若耐受性良好，第二次輸注時間60 分鐘。若 耐受性良好，以後輸注時間 30 分鐘。 | 1. 稀釋濃度應維持在 1.4-16.5 毫克/毫升的範圍內。2. 稀釋後如果未立即使用，通常存放在 2°C-8°C 下最好不要超過 24 小時。3. AlymsysR 並非用於眼球玻璃體內之配方。 |
| IAMI2 | Amiparen 10% inj 200mL (Amino Acids) | IVD; | | | | IVF:100mL/60min | 1. 中央靜脈投與：成人一日400-800mL施行高熱量輸液法。2. 周邊靜脈投與：成人一日200-400mL施行高熱量輸液法。成人標準投與速度為60分鐘內輸注100mL。小孩、老人與重症患者營緩慢注射。 |
| IAMII1 | Aminosteril infant 10% inj 100mL (Amino Acids) | IVD; | | | | Maximum Infusion Rate: Up to 0.1 g amino acids/kg body weight/hr = 1 mL/kg body weight/hr. | 當用於新生兒和2 歲以下兒童時，溶液和輸液袋應避光直至給藥完成。輸注速度太快，可能經由腎臟流失，而造成氨基酸不平衡。 |
| IAMINF | Aminfec inj 250mg/2mL (Amikacin) | EXT;IH;IM;INS; IVD;IVI;SCI; SUBCI; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | 500mg注入100-200mL稀釋液中，投與的時間應超過30-60分鐘；嬰兒需1-2小時。 | |
| IAMIO | Amiodarone (Cordarone) inj 150mg/3mL (Amiodarone) | IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 。 | administer according the ACLS guidelines for ventricular fibrillation/pulseless ventricular tachycardia (300mg 以20mL的5%葡萄糖溶液稀釋後快速注射) | 稀釋濃度不可低於600mg/L(2 Amp in 500 mL D5W)，儘可能從中央靜脈導管點滴給藥(濃度大於2mg/mL需由CVP給藥)，給藥容器與管路應使用非PVC材質。 | 1.稀釋濃度不可低於600mg/L(2 Amp in 500 mL D5W)，稀釋液只能使用等張的葡萄糖溶液。請勿將任何其他的產品加入此輸注溶液中。2.儘可能從中央靜脈導管點滴給藥，濃度大於2mg/mL須由CVP給藥。3.給藥容器與管路應使用非PVC材質(避免DEHP塑化劑溶出與10%藥物被吸附)。4.不可混入Sodium Bicarbonate，會沉澱。5.建議使用0.22micron fillter過濾。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAMP | Ampolin inj 0.5gm (Ampicillin) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | IM: 1.8 mL D/W IV: 5mL D/W | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【L/R】可選 。 | over 3 to 5 minutes | IV infusion: 以50 ~ 100 mL適當輸注液稀釋, 濃度< 30mg/mL。每1gm劑量以至少10至15分鐘時間緩慢滴注, 兒童的滴注速率建議超過30分鐘。NeoFax建議:Doses 500 mg or less should be administered slowly over 3 to 5 minutes IV and over at least 10 to 15 minutes for doses 1 g or greater. Recommended concentrations are 30，40，50，and 100 mg/mL for intermittent IV. For ampicillin 100 mg/mL，consider central line administration due to potential osmolality greater than 600 mOsm/kg. | 1. 注射前檢查病人是否有penicillin (PCN) 過敏史。2. 稀釋液需在一小時內用完。3. 乾粉稀釋:(IM) 0.5 gm/vial 乾粉加入1.8 mL D/W泡製, (IV bolus) 0.5 gm/vial 乾粉加入5 mL D/W泡製。4. IV infusion：以50 ~ 100 mL適當輸注液稀釋, 濃度< 30mg/mL。每1gm劑量以至少10至15分鐘時間緩慢滴注, 兒童的滴注速率建議超過30分鐘。4. IV infusion：以50 ~ 100 mL適當輸注液稀釋, 濃度< 30mg/mL。每1gm劑量以至少10至15分鐘時間緩慢滴注, 兒童的滴注速率建議超過30分鐘。 |
| IANE | Anexate inj 0.5mg/5mL (Flumazenil) | IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | IV over 15~30 seconds | 0.1-0.4 mg/hr IV infusion | |
| IANG | Angidil inj 0.1% 10mL (Isosorbide Dinitrate) | IA;IVD; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | 一般稀釋濃度:100 mcg/mL, 一般輸注速率2-7 mg/hr, 最大輸注速率10 mg/hr, 給藥管路與稀釋溶液應使用「非PVC之材質」。 | 1. 一般稀釋濃度:50 mL Angidil 0.1 % 以適當溶液稀釋至500 mL, 每mL含有100 mcg isosorbide dinitrate。2. 稀釋時應使用玻璃或非PVC之硬塑膠材質容器的稀釋溶液。3. 注射時建議使用聚乙烯(PE)材質的輸注套或硬塑膠材質的針筒幫浦。4. 投藥期間應嚴密監測脈搏與血壓。 |
| IANO | Anol inj 200mg/mL, 100mL/bag (D-Mannitol) | IVD; | | 【N/S】仿單建議。【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【L/R】可選 。 | | 滲透降壓作用:IVD，0.5~2g/kg (as a 15~25% solution), 30~60min 利尿作用:IVD, Adult: 50~100g，Children: 2g/kg，or 60mg/m2 body surface area (as a 5~25% solution)，維持尿液流量 30~50mL/hour. | 1.冬季或冷藏時, 可能產生結晶, 可將其保溫於攝氏40-50度, 待溶解後冷卻至體溫使用。2.請使用附有過濾裝置之輸液套, 導入針應以垂直方式插入橡皮塞, 插入後勿扭轉, 以免產生碎片。3.使用前應再檢視, 確定無異物方可使用。 |
| IANP | Anpo 針劑 50mg/5mL (Ritodrine) | IM;IVD; | | 【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | | 起始: 0.05 mg/min, 維持:0.15 ~0.35 mg/min, 輸注液建議使用D5W, 若使用N/S稀釋, 將增加發生肺水腫之可能性。 | 1. 輸注液建議使用D5W。若使用N/S稀釋, 將增加發生肺水腫之可能性。(衛生署公文:FDA藥字第1001409159號) |
| IANX | Anxicam inj 2mg/1mL (Lorazepam) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【N/S】可選 。 | IV注射速率應2mg/分鐘以下, 用等體積生理食鹽水或注射用水稀釋。 | 應使用non-PVC材質, 用等體積生理食鹽水或注射用水稀釋。 | 1.未稀釋可deep IM。2.IV常用劑量:0.044mg/kg或總量2mg。3.應使用non-PVC材質。4.dilute with an equal volume of compatible solution immediately prior to use; mix thoroughly by gently inverting the container until homogenous; do not shake vigorously. 5.diluted solution may be injected directly into a vein or into the tubing of an existing IV infusion. |
| IARI | Arixtra 2.5mg/0.5mL pre-filled syringe (Fondaparinux) | IVD;SC; | | 【N/S】可選 。 | | 成人:當首次劑量使用IVD方式投予時, 將藥品加入25~50毫升的0.9%生理食鹽水, 靜脈注射需超過2分鐘。 | 1.當血小板數值低於100, 000/mm, 不可使用本藥 2.本藥不可用於肌肉注射 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IASI | Asiphylline inj 250mg/10mL (Aminophylline) | INHL;IVD; | | 【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | | 1.輸注時間應在20分鐘以上。2.以靜脈注射投藥時只能使用25mg/mL之注射液，並且須以靜脈注射液稀釋。3.應以每分鐘25mg的速度緩慢注射，最好事先稀釋。4.Rate of IV infusion should not exceed 7.5 mg/kg over 30 minutes. For IV intermittent therapy，dilute the dose in 50 mL of fluid and infuse over 30 minutes. [Micromedex 20211207] 5. Usual Infusion Concentrations: Adult: IV infusion: 250mg in 250mL (concentration: 1mg/mL) of D5W or NS. [Uptodate (Lexicomp) 20211207] 6. Usual Infusion Concentrations: Pediatric: IV infusion: 1mg/mL. [Uptodate (Lexicomp) 20211207] | 1.單獨給藥，不得加入其他藥物共同輸注。2.In healthy elderly adults (older than 60 years of age): The initial theophylline dose should not exceed 400 mg/day. [Micromedex 20211207] |
| IATR | Atropine sulfate 針劑 1mg/1mL (Atropine) | IM;IVD;IVP; IVPUSH;SC; | | 【N/S】可選 。 | Administer undiluted by rapid IV injection. | 1. 不建議加在大型靜脈注射液內。 | 1. 不建議加在大型靜脈注射液內。2. UpToDate:IV: Administer undiluted by rapid IV injection; slow injection may result in paradoxical bradycardia. In bradycardia，atropine administration should not delay treatment with external pacing. |
| IAVA | Avastin inj 100mg/4mL (Bevacizumab) | IVD; | | 【N/S】可選 。 | | | 1. 輸注溶液不可含葡萄糖。2. 稀釋後輸注溶液應擺放於2-8度C儲存，超過8小時未使用應丟棄。3. 第一次使用建議施打90分鐘，之後視病人耐受程度可縮短輸注時間至30-60分鐘。4. 監測蛋白尿。5. 每2-3週監測血壓變化。 |
| IBCO2 | B-complex 針劑1mL (Thiamine+Riboflavin+Nicotinamide+Pyridoxine) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 文獻不建議IVP給藥 | Thiamine IV route: Dilute with 100 mL of N/S or D5W，and infuse over 30 minutes. (Micromedex) | Thiamine: the risk of hypersensitivity reactions is increased with repeated IV or IM administration.(Micromedex) |
| IBEN | Benlysta inj 400mg (Belimumab) | IVD; | IVD: 4.8mL D/W | 【H/S】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | X | Benlysta should be infused in 250mL infusion solution over a 1 hour period. | 1. The total time from reconstitution of Benlysta to completion of infusion should not exceed 8 hours. 2. Benlysta should not be infused concomitantly in the same IV line with other agents. 3.The 400-mg single-use vial of Benlysta should be reconstituted with 4.8 mL of sterile water for injections to yield a final concentration of belimumab 80 mg/mL. 4.Do not shake. 5.Protect the reconstituted solution from sunlight. |
| IBENA | Benamine inj 30mg/1mL (Diphenhydramine) | IM;IVD;IVPUSH; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 注射速率不宜超過25mg/minute | 成人: 10-50mg (max 400 mg/day); 小孩: 5 mg/kg/day (max 300mg/day) | 1.可靜脈或肌肉深部注射給予。靜脈注射時，注射速率不宜超過5mg/minute。2.早產兒、新生兒及使用單胺氧化酶J抑制劑(MAOI)，勿使用本品。3.老人宜以最低有效起始劑量開始治療。4.窄角性青光眼、消化道潰瘍、幽門十二指腸阻礙、前列腺肥大、膽道阻塞患者應小心使用本品。 |
| IBFL | Bfluid inj 1000mL (Amino Acid + Dextrose + Electrolytes + Vitamin B1) | IVD; | | | | IVD: 150mL/60min，每日最大投與劑量 2500mL | 1. 每日最大投與劑量 2500mL 2. 使用前，用雙手壓上室或下室以打通兩室間的連結處，使二室溶液完全混合。3.成人標準輸注速度為60分鐘內注射150mL(廠商建議)。老人及重症患者應減緩輸注速度。4.廠商建議可在外加K量 周邊靜脈:可再外加20mEq; 中央靜脈可再外加60mEq。5.若有出現結晶請與廠商更換。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBLE1 | Bleocin inj 15mg (Bleomycin) | IA;IM;IVD;SC; | | 【N/S】可選 仿單建議。 | | | 1. 勿使用D5W或其他含有dextrose的稀釋液。2. IM、SQ給藥:15 mg溶於1 mL到 5 mL的NS或注射用水。3. IV 給藥:15 mg溶於 5 mL的NS，緩慢靜脈注射超過10分鐘。4. Intrapleural給藥:溶於50 到100 mL 的NS，經由thoracostomy tube投藥。5. 監測項目:Pulmonary function tests (total lung volume，forced vital capacity，carbon monoxide diffusion)，renal function，liver function，chest x-ray，temperature initially; check body weight at regular intervals |
| IBOL | Bolenic IV infusion 4mg (Zoledronic Acid) | IVD; | 5mL注射用水稀釋 | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | 加入100mL相容輸注液中輸注，IVD > 15 mins，不可使用含鈣或兩價陽離子的溶液 | 1. patients should be adequately hydrated prior to administration 2. If previously refrigerated，allow solution to reach room temperature before administration 3. administer as a single-dose IV infusion in a vented line separate from other drugs; infuse over no less than 15 minutes，over a constant infusion rate 4. Do not allow solution to come in contact with calcium-containing solutions or other divalent cation-containing infusion solutions (eg，lactated Ringer) |
| IBONV | Bonviva inj 3mg/3mL (Ibandronate) | IVP;IVPUSH; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | IV over 15-30 seconds | | 1.不可與含鈣溶液或其他靜脈輸注藥物混合使用2.以15-30秒的時間靜脈推注3mg藥物，使用時務必小心，「不可」將Bonviva注入動脈或靜脈旁側，否則可能造成組織傷害。 |
| IBRID | Bridion inj 200mg/2mL (Sugammadex) | IVP;IVPUSH; | | 【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | IV push over 10 seconds | 不可與其他藥品混合注入，將本藥在10秒內注入現存靜脈注射管線中 | IV: Administer as rapid IV push over 10 seconds; if administered in same IV line as other products，flush with saline before and after administration of sugammadex. The pH is between 7 and 8 and osmolality is between 300 and 500 mOsm/kg. 稀釋後的溶液應立即使用。兒童和青少年(0歲至17歲)，可使用0.9%NaCl將Bridion稀釋至10 mg/mL，以提高給藥的正確性。 |
| IBURO | Burotam inj 2gm (1gm/1gm) (Cefoperazone + Sulbactam) | IVD;IVPUSH; | [仿單]sterile water for injection，D5W，N/S 6-10mL。直接以Cefoperazone/Sulbactam藥瓶配製溶液，每瓶加入適量稀釋液(約6~10mL)，充分振搖至溶解為止。 | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | 注射時間應不少於3分鐘。 | 充分溶解後加入可配伍之靜脈輸注稀釋液使用。Micromedex建議Cefoperazone稀釋至終濃度2 mg/mL至25 mg/mL後可連續輸注，間歇性輸注給藥時間15-30分鐘。 | 1. 稀釋後應讓溶液靜置使泡沫消散。2. Cefoperazone濃度大於 333 mg/mL需要劇烈且長時間的攪拌才能溶解。最大溶解度約為475 mg/mL。3. 配製後之溶液應立即使用。未使用部分，若置於室溫可保存6小時，存放在冰箱內應在48小時內使用。4.Micromedex建議輸注液包含D5W，D5LR，D5NS，5% dextrose and 0.2% sodium chloride injection，D10W，LR，NS，Normosol M and 5% dextrose injection，or Normosol R，稀釋至終濃度2 mg/mL至25 mg/mL後可連續輸注。 |
| ICAG | Calglon 10% inj 10mL (9.3mg/mL) (Calcium Gluconate) | IVD;IVP; IVPUSH;PO; | | 【D10W】可選 。【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | Slow IV < 1.8mEq/min (< 2 mL/min)，推注時間至少 3-5 分鐘；在cardiac arrest 情況下 over 10-20 seconds | 稀釋至50 mg/mL後，以120-240 mg/kg (0.6-1.2mEq calcium/kg) 輸注 > 1 hour | 1. 鈣含量0.46 mEq/mL 2. I.V.: infuse slow IVP over 3-5 minutes or at a maximum rate of 50-100 mg calcium gluconate/minute; in situations of cardiac arrest，calcium gluconate may be administered over 10-20 seconds. 3. I.V. infusion: Dilute to 50 mg/mL and infuse at 120-240 mg/kg (0.6-1.2mEq calcium/kg) over 1 hour 4.不可 I.M. 或SubQ 給藥, IV注射不可外滲，以免發生嚴重組織壞死或脫屑。5.若藥液內出現結晶沉澱，建議可以施壓製品容器，檢視製品是否漏液，出現漏液時，不應使用。若無漏液現象，可能因溫度變化或是因運送過程中，瓶內產生的氣泡，構成晶核，進而析出結晶沉澱。此時可置於65℃水浴內進行溫熱，使結晶溶解，藥液澄清後，方可安心使用。(20211126廠商建議) |
| ICAR2 | Carboplatin inj 150mg/15mL (Carboplatin) | IVD; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | Administer IV over 15 minutes or longer | 1. 鋁會與carboplatin反應而形成沈澱，並使力價喪失。因此，製備或給予carboplatin時，不可以使用含鋁針頭，或可能與藥品接觸部位含鋁的靜脈給藥器組。2. Carboplatin只能以慢速靜脈輸注方式，不應由快速靜脈注射方式給予。3. 通常輸注15分鐘以上，不需要治療前或治療後給大量液體，也不需要強迫利尿。4. 可以用 D5W 或 N/S 進一步稀釋(最低濃度 0.5 mg/mL)；稀釋後8小時內使用。 |
| ICARN | L-Carnit inj 1gm/5mL (L-carnitine) | IVD;IVP; IVPUSH; | | 【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | Administer as a bolus dose over 2 to 3 minutes or by infusion. | Intermittent infusion over 15 to 30 minutes. Drug concentrations ranging 0.5-8 mg/mL. | Compatible when mixed with Normal Saline or Lactated Ringer's in concentrations ranging from 0.5 mg/mL to 8 mg/mL |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEF1 | Cefa inj 1gm (Cefazolin) | IM;INS;IRR;IRRI;IS;IVD;IVP;IVPUSH; | IM: 3.5 mL D/W; 4.5 mL N/S; 4.5mL D5W IV: 7mL D/W; 9mL N/S; 9mL D5W | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【D5NS】可選 。【L/R】可選 。 | 推注時間至少 5分鐘 | 給藥濃度10-20 mg/mL，以30~60分鐘輸注。 | 1. 監測體溫、CBC、肝腎功能、PT值。2. 注意是否發生抗生素引起的腹瀉。3. (IM) 1gm/vial 乾粉加入3.5 mL D/W 泡製。4. (IV bolus) 1gm/vial 乾粉加入5 mL D/W 泡製，再加入5 mL稀釋液，緩慢推注至少3 ~ 5分鐘。小兒給藥建議: IV push，50-100 mg/mL over 3-5 minutes. In fluid-restricted patients, 138mg/mL has been administered. Intermittent infusion，5-20 mg/mL over 10-60 minutes. |
| ICEFI2 | Cefin inj 2gm (Ceftriaxone) | IVD;IVPUSH; | 靜脈注射: Ceftriaxone 2g溶於20ml的滅菌注射用水。肌肉注射(現行仿單並未提供此用法): 2g溶於7ml的1% Lidocaine溶液，臀肌深部注射。Lidocaine 溶液絕對不能作靜脈注射。 | 【D10W】可選 。【D2.5HS】可選 。【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 靜脈注射的時間應超過2-4分鐘。 | 輸注時間至少需30分鐘。 | 1. 本藥品勿與含鈣或其他抗生素溶液混合，即使使用同一個注射管線，也會產生沉澱。2. 通常溶液在調配完成後應立即使用，調配後之溶液在室溫下穩定性可維持6小時，或在2-8oC冰箱下可達24小時。3. 新生兒以外之病人，如果可以在兩次輸注之間徹底以可相容的溶液沖洗輸注管，則可以相繼使用Ceftriaxone與含鈣溶液。4. Monitor INR during treatment if patient has impaired synthesis or low stores of vitamin K; supplementation may be needed if clinically indicated. [Lexi-Drug] 5. Lidocaine 溶液絕對不能作靜脈注射。注射於身體較大的肌肉，且每邊注射的建議劑量不可超過1g。 |
| ICEFT | Cetazine inj 1gm (Ceftazidime) | IM;IMP;IVD;IVI;IVP;IVPUSH;SCI;SUBCI; | IM: 3.5 mL D/W; IV: 10mL D/W，N/S，D5W | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【D5NS】可選 。【L/R】可選 。 | 推注時間至少3 ~ 5分鐘 | 給藥濃度20mg/mL，以20 ~ 30分鐘緩慢滴注 | 1. 注射前詢問病患是否有β-醯胺類抗生素過敏史。2. 監測體溫、CBC、肝腎功能、PT值，注意是否發生抗生素引起的腹瀉。3. 2020/11/26詢問廠商: 2-8度C保存，主成份安定性為4天。 |
| ICHE | Chenday inj 25mg/5mL (Labetalol hydrochloride) | IVD;IVPUSH; | | 【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。 | 至少要一分鐘以上。 | 稀釋成1mg/mL，輸注速率每小時約20mg-160mg。 | 1. 靜脈注射Labetalol hydrochloride注射液後三小時內病人應避免成直立姿勢以免可能造成過度的姿勢性低血壓。 |
| ICHIA | Chiaowelgen inj 10mg/2mL (Metoclopramide Hydrochloride) | IM;IVD;IVPUSH; | | 【N/S】可選 。 | IV push undiluted over 1 to 2 minutes. (Lexidrug 20250522) | higher doses (>10 mg) to be diluted in 50 mL of compatible solution (preferably Normal Saline) and given IVPB over at least 15 minutes. (Lexidrug 20250522) | 1. 使用含metoclopramide成分藥品可能造成遲發性運動障礙(tardive dyskinesia)，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量(total cumulative dose)有正相關性。故不建議長期(超過2週)使用本品治療。2. 極少數兒童發生嗜睡或輕微肌肉緊張，此種現象為暫時性，停止用藥，保持安靜，症狀即會消失。3. 使用metoclopramide於小於18歲之族群，且應從低劑量作為起始劑量，並慢慢提高至最低有效劑量，如出現肌張力不全或錐體外路徑反應，應立即停藥。 |
| ICIS | Cisplatin 50mg/50mL (Cisplatin) | IVD; | | 【N/S】可選 。 | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 調配與注射cisplatin的器具不可含有鋁。3. 稀釋後的輸注溶液應避光保存。4. 給藥前後應給予病人適當水分補充。5. 監測CBC、肝腎功能。6. 定期神經學、聽力檢測。 |
| ICLA1 | Claforan inj 1gm (Cefotaxime) | IM;IVD;IVP;IVPUSH; | IM: 4 mL D/W;IV: 10mL D/W | 【D5NS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。 | 推注時間至少3 ~ 5分鐘 | 建議以20~60分鐘緩慢滴注。NeoFax建議:For IV push，a concentration of 50 to 100 mg/mL may be used. For intermittent IV infusion，dilute to a concentration of 10 to 40 mg/mL and infuse over 10 to 30 minutes. | 1. 注射前詢問病患是否有β-醯胺類抗生素過敏史。2. 監測體溫、CBC (尤其使用超過10天)、肝腎功能、PT值，注意是否發生抗生素引起的腹瀉。3. (IM) 1 gm/vial 乾粉加入4 mL D/W泡製。4. (IV bolus) 1 gm/vial 乾粉加入10 mL D/W泡製，兒童使用的藥液濃度< 50 mg/mL，推注至少3 ~ 5分鐘。5. (IV infusion) 1 - 2gm 乾粉稀釋成40 ~ 100 mL，以20 ~ 60分鐘緩慢滴注 小兒給藥建議:IV push，200 mg/mL via central catheter and 60 mg/mL via peripheral vein over3-5 minutes. Intermittent infusion，10-60 mg/mL over10-30 minutes. |
| ICLAR2 | Clariscan inj 0.5 mmol/mL，20mL/Bot (Gadoterate meglumine) | IV;IVP;IVPUSH; | | | Administer as an IV bolus injection. Infuse at a rate of approximately 2 mL/second. To ensure complete injection of contrast agent，flush line after administration. | | 給藥後，應至少觀察半小時，因為臨床經驗顯示大部分不良反應發生在這段時間內。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLEX | Clexane inj 60mg/0.6mL (Enoxaparin Sodium) | IVPUSH;SC; | | | 1. 應經由靜脈留置管給藥。本藥物不可與其他藥物混合或同時注射。2. 靜脈注射管路在enoxaparin sodium注射前或注射後，應以足量的生理食鹽水或葡萄糖溶液沖洗以清除藥物。3. 可以安全地與生理食鹽水（0.9%）或5%葡萄糖溶液混合後一起注射。4. 為了確保注射少量體積的準確性，建議將藥品稀釋成300 anti Xa-IU/ml。為了製備3 mg/ml 的溶液，建議使用預填enoxaparin sodium 60 mg注射器及50 ml的輸注袋（例如，使用生理食鹽水（0.9%）或5%葡萄糖溶液），製備方法如下：從輸注袋中抽出30 ml之液體將其丟棄，並將預填enoxaparin sodium 6000 anti-Xa IU注射器內的所有內容物注射至輸注袋剩餘的20ml溶液中。將輸注袋中的內容物輕輕混合，以針筒抽取所需的稀釋溶液體積以供注入靜脈留置管路中。藥品稀釋完成後，可運用下列公式〔稀釋溶液的體積（ml）= 病患體重（kg）x 0.1〕或使用下列表格來計算所需要的注射體積。藥品應在使用前才稀釋。 | | 1. 皮下注射給藥(ST-波段升高的急性心肌梗塞患者及進行血液透析治療的患者除外，這些患者應施以靜脈注射）。2. 本藥物不可以肌肉注射給藥。3. 注射前應先丟棄多餘的注射溶液。若注射溶液沒有多餘，則注射前不需先排除注射器內的空氣。4. 患者以仰臥的姿勢注射較佳。注射部位應交替選擇腹壁的左、右前外側及後外側。5. 將皮膚以拇指及食指捏起，然後把整支針頭的長度垂直插入皮膚內，不要斜著插入。注射過程中應捏住皮膚皺摺，直到注射完畢為止。 |
| ICLI3 | Clincin inj 300mg/2mL (Clindamycin) | IM;IRR;IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【D5NS】可選 。 | | 1. 必須先稀釋成濃度在12 mg/mL以下，然後再輸注投與。2. 每次投與1小時內不可超過1200 mg，而且避免延長使用輸液管。 | |
| ICOL | Colimycin inj 2MU (Colistin Methanesulfonate) | IH;IM;IVD; | IM: 2 mL D/W，N/S; IV: 2mL D/W，N/S，D5W | 【L/R】可選 。【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 推注時間至少3 ~ 5分鐘 | 開始的1~2小時，以5-6mg/hr緩慢滴注 | 1. 輸注液需新鮮配製，室溫下只能擺放24小時 2. 腎功能不全病患需減慢注射速率。 |
| ICOV | Covorin inj 50mg/5mL (Folinate) | IM;IVD;IVPUSH; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | <160 mg/min | IV infusion over 15 minutes to 2 hours. | 1. IV maximum rate: 160 mg/min. [Micromedex] 2. Administer as IM，IV push，or IV infusion. 3. Do not mix with 5-fluorouracil in the same infusion. |
| ICRA2 | Cravit 針劑 250mg/50mL (Levofloxacin) | IVD; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | Infuse 250 mg IV solution over 30 minutes; infuse 500 mg IV solution over 60 minutes; infuse 750 mg IV solution over 90 minutes. Too rapid of infusion can lead to hypotension. | 1. 需避光儲存，光照下藥效只能維持3天。2. 輸注時監測BP，輸注過快可能發生低血壓。3. 管路避免與含鈣、鎂離子溶液接觸。4. 依2016年第2次ADR會議決議：因Quinolones類藥物常見引起靜脈炎，建議輸注時間應超過60分鐘。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICUB | Cubicin inj 500mg (Daptomycin) | IVD;IVPUSH; | 10 mL之0.9%氯化鈉注射液 | 【N/S】可選 仿單建議。 | 僅限於成人病人給予2分鐘靜脈(IV)注射。 | 成人: 將調配後Cubicin（濃度為50 mg/mL）進一步稀釋至含有0.9%氯化鈉注射液之50毫升靜脈輸液袋中, 30分鐘靜脈(IV)輸注。1至6歲兒童: 將調配後Cubicin（濃度為50 mg/mL）進一步稀釋至含有0.9%氯化鈉注射液之25 mL靜脈輸液袋中, 60分鐘靜脈輸注, 輸液速率應維持於0.42 mL/分鐘。7至17歲兒童: 將調配後Cubicin（濃度為50 mg/mL）進一步稀釋至含有0.9%氯化鈉注射液之50 mL靜脈輸液袋中, 30分鐘靜脈輸注, 輸液速率應維持於1.67 mL/分鐘。 | 1. 配製藥液時或之後, 請避免劇烈震動或搖晃藥瓶, 以減少泡沫形成。2. 建議使用21號或更小直徑之斜面針頭。3. 配置時請靜置浸濕之內容物10分鐘, 輕輕轉動或旋轉藥瓶內容物數分鐘, 充分混勻藥液。4. 調配完成的注射液於小瓶中, 室溫可保存12小時, 在2-8°C可儲存48小時。稀釋溶液在注射袋中, 室溫可保存2小時, 或在冷藏下可保存48小時。兩者合併的儲存時間（小瓶中的濃縮液及注射袋中的稀釋液）, 於室溫保存不可超過2小時；冷藏時不可超過48小時。5. Cubicin與含葡萄糖稀釋液不相容。6. 使用相同的靜脈注射管連續注射不同的藥物, 在注射Cubicin前後, 需以可相容的靜脈注射溶液沖洗該靜脈注射管。 |
| ICUL5 | Culin inj 500/500mg (限影像醫學科自費臨採) (Imipenem + Cilastatin) | IA;IVD; | 乾粉以10mL相容輸注溶液溶解 (NS，D5W, D10W，D5NS，D5/0.45NS), 再移入輸注容器稀釋為100mL使用。 | 【D10W】可選 仿單建議。【D5NS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。 | | <=500mg, 滴注時間需大於20-30分鐘;>500mg, 滴注時間需大於40-60分鐘。 | 1. 已調配之稀釋液可存放於室溫(25°C)4小時或冷藏(2-8°C)24小時。 |
| ICYR | Cyramza inj 100mg/10mL (Ramucirumab) | IVD; | | 【N/S】可選 仿單建議。 | Do not administer as an IV push or bolus. | Dilute with only 0.9% saline to a final volume of 250 mL. Infuse over 60 minutes through a separate infusion line using an infusion pump; the use of a 0.22 micron protein sparing filter is recommended. Do not administer as an IV push or bolus. Flush the line with NS after infusion is complete. | Do not administer as an IV push or bolus. Do not use dextrose containing solutions. Dilute with only 0.9% saline to a final volume of 250 mL. Infuse over 60 minutes through a separate infusion line using an infusion pump; the use of a 0.22 micron protein sparing filter is recommended. |
| IDDA | Minirin inj 4mcg/1mL (DDAVP) (Desmopressin) | IVD; | | 【N/S】可選 。 | | Adult: IV: 0.3 mcg/kg dilute to 50-100mL with N/S by slow infusion over 15-30 min, repeated every 6-12 hours one to two times if needed. Maximum IV dose: 20 mcg. | Adminisration (Intravenous) 1.dilute in sterile physiological saline (diluent); use 10 mL diluent if patient 10 kg or less; use 50 mL diluent if patient more than 10 kg 2.infuse over 15-30 min 3.give 30 min prior to surgical procedures if need to give preoperatively 4.fluid restriction recommended 須於冰箱2-8℃冷藏儲存, 如果儲存於室溫25℃以下儲存, 最多可保存4週, 超過4週須丟棄, 一經室溫存放後則不可再放回冰箱冷藏儲存。 |
| IDEP4 | Depakine 針劑 400mg (Valproate Sodium) | IVD; | 將4毫升注射用水注入小瓶中, 藥粉溶解後再取出所需劑量加入點滴中。 | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | 注射速率 < 20mg/min;先15mg/kg slow IV >5mins，再1mg/kg/hr | 使用前應先調劑, 將4毫升注射用水注入小瓶中, 藥粉溶解後再取出所需劑量加入點滴中。 |
| IDES | DesFERAL inj 500mg (Deferoxamine) | IM;IVD;SC; | 需先以5ml注射用水稀釋成10% Desferal, 方可使用。 | 【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | | 注射速率 < 15mg/kg/hr | 1.限用5mL注射用水溶解乾粉, 不可用 0.9% N/S作為乾粉藥劑之溶劑2.溶解後可用0.9% N/S做進一步的稀釋 |
| IDEX | Dextran (血賜多朗滴) inj 500mL (Low Molecular Dextran Dextrose) | IVD; | | | | 注射速率:20~40mL/mins, Max:20mL/kg/day | 1.未稀釋亦可使用2.Max:20mL/kg/day |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXA | Dexamethasone inj 5mg/1mL (Dexamethasone) | ID;IM;INS;IRR; IS;IVD;IVI;IVP; IVPUSH;LI;SCI; SUBCI; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 靜脈推注需大於一分鐘 | Consider further dilution and administration by IV intermittent infusion over 5 to 15 minutes. (UpToDate) | 一日總投與量不可超過80mg;用於皮內通常將之用生理食鹽水稀釋5倍後取約0.1 mL;點眼通常稀釋25倍後來使用 Adult: May administer 4 mg/mL or 10 mg/mL concentration undiluted over >1 minute. (UpToDate) |
| IDIAG | Diagnogreen inj 25mg (Indocyanine Green) | IVP;IVPUSH; | 使用廠商提供之10mL注射用水稀釋 | | Max: 2 mg/kg/dose. | | |
| IDIG2 | Lanoxin inj 0.5mg/2mL (Digoxin) (Digoxin) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【H/S】可選 。【L/R】可選 。 | May be administered undiluted or diluted. Inject slowly over ?5 minutes. | IV infusion over 10-20 mins | 1.未稀釋亦可使用 |
| IDIPE | Dipeptiven inj 100mL (Alanine 8.2% + Glutamine 13.64%) | IVD; | | 【D10W】可選 。【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | < 0.1 g amino acid/kg/hr (dilution:Dipeptiven 100 mL + Compatible solution 500 mL) | 1. Dipeptiven should be mixed with a compatible amino acid carrier solution or an amino acid-containing infusion regimen prior to administration. 2. One part volume of Dipeptiven is to be mixed with at least 5 parts volume of carrier solution (eg, Dipeptiven 100 mL + amino acid solution at least 500 mL). Water rationing:dilute Dipeptiven to an osmolarity =< 800 mosmol/l (e.g. 100 ml Dipeptiven + 100 mL saline.) 3. The maximum concentration < 3.5%. The duration of use should not exceed 3 weeks. |
| IDOB2 | Gendobu inj 250mg/20mL (Dobutamine) | IVD; | | 【D10W】可選 。【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | | 2.5-10 mcg/kg/min as IV infusion | 1.勿加入鹼性藥品 2.開封後請於24小時內用完 3.靜脈輸注部位之反應一偶而發生靜脈炎的報告，不小心的輸注滲漏引發局部發炎的變化。曾有皮膚壞死個案報告（破壞皮膚組織）。 |
| IDOPA | Dopamin inj 200mg/5mL (Dopamine) | IVD; | | 【D5NS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | Initiate at a rate of 2~5 mcg/kg/min increment up to 20-50 mcg/kg/min if needed | 1.勿加入鹼性藥品 2.注射時應選較大靜脈，最好是肘前窩，以防止外溢而引起組織壞死和環繞組織腐肉生成如有必要需由手或足踝靜脈給藥時，注射部位仍應儘速改變到較大的靜脈 如有劑量外溢發生時，立刻以含5-10mg Phentolamine Mesylate之0.9%Sodium Chloride注射液10-15mL浸潤患部以防止腐肉生城和壞死. |
| IDOR | Dormicum inj 5mg/1mL (Midazolam) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5NS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【H/S】可選 。 | 緩慢推注，成人注射20-30 秒，孩童注射>2-3分鐘。下次投藥前至少等待 2 分鐘，觀察是否已發揮足夠藥效。 | 成人0.03-0.1 mg/kg/hour，孩童0.06-0.12 mg/kg/hour，>32週新生兒0.06 mg/kg/hour，<32週新生兒0.03 mg/kg/hour。 | 1. IM: 注射於大型肌肉之深部。2. IV: 緩慢推注，成人注射20-30 秒，孩童注射>2-3分鐘。下次投藥前至少等待2 分鐘，觀察是否已發揮足夠藥效。3. 持續 IV infusion: 成人0.03-0.1 mg/kg/hour，孩童0.06-0.12 mg/kg/hour，>32週新生兒0.06 mg/kg/hour，<32週新生兒0.03 mg/kg/hour。4. Dormicum inj 5mg/1mL可使用適當溶液稀釋為0.015-0.15mg/mL濃度。5. Dormicum inj 5mg/1mL不可與鹼性溶液混合，會產生沉澱。 |
| IDOX | Doxor lyo inj 10mg (凍晶) (Doxorubicin) | IA;IRR;IVD; | Dissolve using provided solvent 5mL (ampoule) - Water for injection | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 監測CBC、肝腎功能、尿酸與血中電解質濃度。3. 本品稀釋後，在室溫避光下可保存24 小時，但在 4°C~10°C 時可保存 48 小時。 |
| IDRO | Dropel inj 2.5mg/1mL (Droperidol) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | | IV push administration should be slow. | | 緩慢注射，成人最大初始劑量2.5mg;小孩(2-12歲)最大初始劑量0.1mg/kg |
| IDUP | Diazepam(Dupin) inj 10mg/2mL (Diazepam) | IM;IVPUSH; | | | 推注速率< 5 mg/min | 1.本藥不可與其它溶液、靜脈輸注液或其他藥物混合或稀釋，因為有使Diazepam 沈澱之可能，而且Diazepam 會被輸液袋及輸液管所吸附，因此本藥不宜作靜脈輸注。2.如果不能直接靜脈注射，也可緩慢注入輸液管內，但要盡量接近注射點(Insertion Point)。3.靜脈注射時，應勿使用手背或手腕之小靜脈，而且還要避免注射到血管外，也勿作動脈注射，以防靜脈栓塞、靜脈炎、局部刺激、腫脹以及血管損傷。 | 1. IM: inject deeply into muscle mass. 2. IV: inject slowly; do not administer faster than 5 mg/min. Do not use small veins for injection; if direct injection is not feasible, may inject through infusion tubing as close as possible to the vein insertion. 3. Do not mix or dilute with other solutions or drugs in syringe or infusion flask. |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDUR | Duratocin inj 100mcg/1mL (Carbetocin) | IVP;IVPUSH; | | | Slow IV < 100mcg/1min | | 1.不可與其他藥物混合2.對Carbetocin或oxytocin過敏者禁用 |
| IDYN | Dynastat inj 40mg (Parecoxib) | IM;IVP;IVPUSH; | IM: 2mL N/S, D5W IV: 2mL N/S, D5W | | 如採靜脈注射, 可直接迅速地注入靜脈. (Intravenous parecoxib has been given as a bolus over at least 15 seconds [Micromedex 20220822]) | 本藥無IVD用法相關建議。 | 1.剝除parecoxib 40毫克小瓶的紫色易拉蓋。2.用無菌注射針與針筒抽取2公撮適當的溶劑, 將溶劑注入40毫克小瓶內。3.輕輕旋轉小瓶, 使粉末溶解, 調配完成後的注射液應為澄清溶液。4.注射前, 應目視檢查Dynastat注射液是否變色或有不溶物質, 注射液一旦變色、渾濁或有不溶物質, 則不得使用5.調配完成之Dynastat注射液應立即, 否則應予以丟棄。6.調配完成的溶液是等張溶液。 |
| IEMA | Emazole inj 40mg (Esomeprazole) | IVD;IVPUSH; | N/S | 【N/S】可選 仿單建議。 | 注射時間須至少持續3分鐘。 | <40mg: 輸注時間10-30分鐘, 剩餘溶液應丟棄。>80mg: 輸注時間30分鐘。 | 1. 調配完成後之儲架期:在30oC以下, 其化學及物理上之安定性已被證明12小時內沒有問題, 但從微生物學觀點來看, 調配完成之藥品應立刻使用。2. 調配完成之溶液的降解對於pH有高度依賴性, 因此本品只能以0.9%氯化鈉溶液調配後用於靜脈注射。3. 調配完成之溶液不應在同一靜脈輸液管中, 與其他藥品混合或同時給藥。 |
| IENC | Encore inj 300mg/3mL (Acetylcysteine) | IH;IM;IVD; | | 【D5W】可選 。【H/S】可選 。 | | 建議以>60分鐘緩慢滴注 | 1. IV用於Acetaminophen過量的成人劑量: loading dose, 150 mg/kg in 200 mL of compatible solution IV over 60 minutes, then 50 mg/kg in 500 mL of solution IV over 4 hours, followed by 100 mg/kg in 1000 mL of solution IV over 16 hours. |
| IEND5 | Endoxan inj 500mg (Cyclophosphamide) | IVD; | 0.9% sodium chloride 25mL | 【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | | |
| IENH | Enhertu inj 100mg (Trastuzumab Deruxtecan) | IVD; | Sterile Water for Injection 5 mL per 100 mg vial | 【D5W】可選 仿單建議。 | | Reconstitute each 100 mg vial with 5 mL of Sterile Water for Injection (final 20 mg/mL). Dilute in 100 mL of 5% Dextrose Injection. FIRST infusion over 90 minutes; subsequent infusions over 30 minutes if prior infusions were well tolerated. Cover the infusion bag to protect from light. Administer with an infusion set made of polyolefin or polybutadiene and a 0.20 or 0.22 micron in-line polyethersulfone (PES) or polysulfone (PS) filter. | 1. 若出現輸注相關症狀, 應降低輸注速率或中斷輸注。若發生嚴重輸注反應, 應永久停用。2. 從藥品配置完到施用結束, 時間最長不宜超過24小時, 遮蓋輸注袋以避免光線照射。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IENT | ENTYVIO inj 300mg (infusion) (Vedolizumab) | IVD; | 4.8mL注射用無菌水、N/S、L/R | 【L/R】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | 1. 以靜脈輸注30分鐘方式給予，請勿以靜脈注射或推注方式給藥。2. 輸注完成後使用30mL的N/S或L/R沖洗。配製: 1. 在20-25oC下使用21至25 gauge針頭，以4.8mL注射用無菌水配製。2. 針頭插入並導引注射用無菌水沿藥瓶玻璃壁流下，以免產生泡沫。3. 輕晃動至少15秒，勿用力搖晃或倒轉。4. 室溫下靜置最多20分鐘，以便配製並等所有泡沫消失，如未完全溶解，可再放置10分鐘。未在30分鐘內溶解，勿使用此藥。5. 溶液應為清澈或半透明，無色至淺棕黃色，不含顆粒。若溶液顏色異常或含顆粒，勿使用。6. 輕倒轉藥瓶三次，再抽取配製好的溶液5mL。藥瓶內剩餘的溶液請丟棄。稀釋: 將5毫升(300毫克)配製完成的安潰悠溶液，加入250毫升的無菌0.9%氯化鈉注射液或乳酸林格爾注射液，並輕輕晃動輸注袋。請勿將其他藥品加入準備好的輸注溶液或靜脈輸注管線組。輸注溶液配製完成並稀釋後，請儘快使用。 | 儲存: 配製後應立即使用，如冷藏可保存8小時。稀釋於N/S後20-25oC可保存12小時，2-8oC冷藏可24小時(包含最多12小時的室溫儲存時間)。稀釋於L/R後應立即使用，2-8oC冷藏可6小時。 |
| IEP10 | Epicin 10mg/5mL (Epirubicin) | IA;IRR;IVD; | | 【D5NS】可選 仿單建議。<br>【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 監測CBC、肝腎功能、尿酸與血中電解質濃度。3.Epirubicin的累積劑量與心臟毒性相關，將累積劑量限制在1000mg/m2以下可以降低相關風險 |
| IEP50 | EPICIN 50mg/25mL (Epirubicin) | IA;IRR;IVD; | | 【D5NS】可選 仿單建議。<br>【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 監測CBC、肝腎功能、尿酸與血中電解質濃度。3.Epirubicin的累積劑量與心臟毒性相關，將累積劑量限制在1000mg/m2以下可以降低相關風險 |
| IEPH | Ephedrine inj 40mg/1mL (Ephedrine) | IM;IVP;IVPUSH; SC; | | 【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 稀釋到5-10mg/mL，緩慢靜脈推注 | | 1.IV: 稀釋到 5 - 10 mg/mL，緩慢靜脈推注。2. 監測血壓、心跳變化。 |
| IERAX | Eraxis inj 100mg (Anidulafungin) | IVD; | 100-mg vial: Sterile Water for Injection 30 mL. 200-mg vial: Sterile Water for Injection 60 mL. | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | 100-mg dose (130 mL: 30 mL of drug and 100 mL of solution) infused over 90 minutes. 200-mg dose (260 mL: 60 mL of drug and 200 mL of solution) infused over 180 minutes. | 1. 給藥前，每100毫克小瓶須以30毫升無菌注射用水溶解，再以100毫升的5%葡萄糖注射液或0.9%氯化鈉注射液稀釋為輸注溶液。不可與其他藥物或電解質一同輸注。2. 劑量100毫克時總輸注液量為130毫升(30mL drug + 100mL solution)，輸注液濃度是0.77 毫克/毫升，最短輸注時間90分鐘。劑量200毫克時總輸注液量為260毫升(60mL drug + 200mL solution)，輸注液濃度是0.77 毫克/毫升，最短輸注時間180分鐘。3. 輸注速率不可超過1.1 毫克/分鐘。最高輸注速率 1.4 毫升/分鐘或 84 毫升/小時。4. 配製好的溶液可儲存在25oC可存放達 24 小時。稀釋為輸注溶液後，在不超過25℃下最多可存放48小時。不可冷凍。 |
| IERB2 | Erbitux inj 100mg/20mL (Cetuximab) | IVD; | | | | Administer through a low protein-binding 0.22 micrometer in-line filter. Administer via infusion pump or syringe pump at a rate not to exceed 10 mg/minute. Do not administer as IV push or bolus. Do not shake or dilute. | 1. 輸注本藥品一定要單獨使用一條管線，輸注結束時一定要用無菌的生理食鹽水沖洗管線。2. 配製後，使用中的化學和物理安定性在25°C 下維持48小時。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IESC | Escopan inj 20mg/1mL (Hyoscin-Butylbromide) | IM;IV;IVD;IVP; SC; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 推注時間至少>1分鐘 | | |
| IETOM2 | Hypnomidate inj 20mg/10mL (限麻醉科) (Etomidate) | IVD;IVPUSH; | | 【D10W】可選 仿單建議。 【D5W】可選 仿單建議。 【H/S】可選 仿單建議。 【N/S】可選 仿單建議。 | 推注時間>30秒 Administer IV push over 30 to 60 seconds. | | 1. Etomidate-Lipuro未作相容性測試前，不得與其他輸注液混合。此外，除非已確認相容性，否則Etomidate-Lipuro不得同時與其他注射液以同一輸注管給予；需要合併給予之藥物如止痛劑，以同一輸注管或個別靜脈插管接續給藥。2. Etomidate-Lipuro不含抗菌防腐劑。因為脂肪乳劑會促進微生物生長，安瓿開瓶後應於無菌狀態下立即以注射器抽出並輸注。剩餘部份應丟棄。3. 投予Etomidate-Lipuro前應適度前驅給藥以避免肌陣痙的發生。建議於投藥前小時IM給予或10分鐘前IV給予BZD類藥物。4.Hypnomidate與 compound sodium lactate輸注液(Hartmann's 溶液)不相容。與pancuronium bromide注射液混合時可能時會出現輕微混濁，故應避免將這兩種注射液混合。 |
| IETP | Ertapenem inj 1gm (Ertapenem) | IM;IVD; | IVD: Reconstitute 1gm vial with 10mL water for injection or Normal Saline 10mL. Shake well. Deep IM: Reconstitute 1 gm vial with 3.2 mL of lidocaine HCl 1% or 2% injection (without epinephrine). Shake well. Use within 1 hour of preparation. | 【N/S】可選 仿單建議。 | | After reconstitution，further dilute dose with Normal Saline; for adolescents and adults (age >= 13 years), transfer dose to 50 mL Normal Saline; for children (3 months to 12 years)，dilute dose to a final concentration<=20 mg/mL. Infuse over 30 minutes; complete infusion within 6 hours of reconstitution. | 1. 不可以將Ertapenem for Injection與其他藥品混合或同時輸注。2. 不可以使用含有葡萄糖(α-D-GLUCOSE)的稀釋液。3. 注射乾粉經溶解並立即以0.9%氯化鈉注射液50mL稀釋後，可放在室溫(25°C)於6小時內使用，也可冷藏(5°C)至多24小時，自冷藏取出後須於4小時內使用。不可冷凍。 |
| IEYL | Eylea aflibercept 2mg/0.05mL (Aflibercept) | IVI; | | | | | 僅供眼科玻璃體內注射用。EYLEA 必須由合格醫師注射。 |
| IEYL8 | EYLEA inj 8mg/0.07mL (114.3mg/mL) (Aflibercept) | IVI; | | | | | 1. 玻璃體內注射後，應馬上監測病人的眼壓是否升高。2. 每個藥瓶只能用於治療一隻眼睛。3. 過濾針頭使用前請勿高溫高壓滅菌。4. 進行玻璃體內注射，應使用30-gauge英吋的注射針頭。 |
| IFEB | Fe-Back inj 2%，5mL (Ferric-Hydroxide-Sucrose Complex) | IVD;IVP; IVPUSH; | | 【N/S】可選 。 | 緩慢注射，每分鐘1mL (20mg 元素鐵) 速率，每瓶5 mL 推注時間至少 5 分鐘。 | 建議 5 mL Fe-Back 稀釋成100 mL，以大約15分鐘時間滴注，若劑量 > 120mg 滴注需 2 小時。(Fe-Back 每 mL 含有 400 mg Ferric-Hydroxide-Sucrose Complex，相當於20mg iron) | 1.本藥品需緩慢靜脈注射，建議速率:1 mL/分鐘，單次注射不要超過10 mL。2.初次使用前應先用測試劑量1 mL，觀察30分鐘，確定無任何不良反應，？如頭？、臉水腫、呼吸困難3.靜脈滴注建議使用0.9%生理食鹽水稀釋。5 mL Fe-Back inj 2% 稀釋成100 mL，以大約15分鐘時間滴注。4.？病人之前曾使用含鐵成分針劑藥品發生過敏反應，或患有免疫或發炎？如？風溼性關節炎)相關疾病，或有氣喘、濕疹、過敏病史，應主動告知醫師。 |
| IFEN10 | FENTANYL inj 0.5 mg/10mL (Fentanyl) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 推注時間成人 > 1-2分鐘，兒童 > 2-5分鐘 | Usual Infusion Concentrations IV infusion: 10 mcg/mL | |
| IFEN2 | Fentanyl inj 0.1mg/2mL (Fentanyl) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 推注時間成人 > 1-2分鐘，兒童 > 2-5分鐘 | | |
| IFLU10 | Fluorescite 10% 5mL (Fluorescein) | IVP;IVPUSH; | | | Adult: 500 mg (as a 10% soln) over 5-10 sec into the antecubital vein. (1 mL/second) | | 1. Prior to injection，an intradermal test dose of 0.05 mL may be used if an allergy is suspected. Evaluate 30-60 minutes following intradermal injection. A negative skin test does not exclude the potential for a reaction to occur. 2.IV: Inject into the antecubital vein at a rate of ~1 mL/second using a 23-gauge butterfly needle attached to a small syringe. Prior to turning off room light, ensure extravasation has not occurred. |
| IFLU2 | 5-FU inj 1000mg/20mL (Fluorouracil) | IVD; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 監測CBC、血糖變化 (DM病人)。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFLUC | FLUcon inj 200mg/100mL (Fluconazole) | IVD; | | | | Infusion rate <=10 mg/minute (5 mL/minute) | 1. 注意是否發生皮膚疹、腹痛症狀。2. 監測肝腎功能與心電圖變化。3. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應垂直插入橡皮塞，插入後請勿扭轉。(20241223致電廠商，信東產品經理表示，此條項為早年法條規定抗生素輸注液皆須註明，目前已無此法條，會在未來修改仿單時一併修正) 4. 每200毫克(100毫升瓶裝) 各含15mmol的鈉離子和氯離子。 |
| IFMR | Flumarin inj 1gm (Flomoxef) | IVD;IVPUSH; | 1g的vial包裝，以4mL以上的注射用水, 5%葡萄糖注射液，或生理食鹽水加入後溶解. | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 緩慢注射3分鐘 | 仿單無建議滴注時間，但動力學資料是將藥物以1小時點滴輸注. | 1. 調配後室溫可保存6小時，冷藏可保存24小時。2. 仿單無稀釋後安定性資料。2021/1/24廠商提供安定性資料，1g稀釋於5%葡萄糖注射液或生理食鹽水100mL或500mL在攝氏25度以下可有6小時安定，冷藏可有24小時安定。3. 臨床試驗中靜脈注射flomoxef 1g給藥時間為3分鐘內，緩慢注射可能避免給藥不適。 |
| IFOR10 | FORMOXOL inj 60mg/10mL (Paclitaxel) | IVD; | | | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 稀釋溶液與器具應使用玻璃、聚丙烯(polypropylene)、聚烯(polyolefin)材質，不可使用含DEHP的PVC塑膠材質。3. 配製好的輸注溶液濃度在0.3 - 1.2 mg/mL，室溫下安定性維持27小時。4. 注射前應先給予預防過敏的藥物。輸注開始的第一個小時應監測Vital Sign。5. 曾使用 Paclitaxel發生心臟傳導異常的病人，之後使用Paclitaxel期間應進行連續心電圖監測。6. 監測CBC。7.含有蓖麻油成分，容易造成病患過敏反應，施打時應由低速率開始調整，並注意病人反應。 |
| IFOR25 | FORMOXOL inj 150mg/25mL (Paclitaxel) | IVD; | | 【D5NS】可選 仿單建議。<br>【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | 0.3 - 1.2 mg/mL infuse over 3 or 24 hours (depending on indication/protocol). | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 未經稀釋的藥液不宜接觸到製備輸注溶液的PVC設備或儀器，塑化劑DEHP很容易由PVC輸注袋或器具中溶解出來。稀釋過的溶液最好儲存在瓶子(玻璃、聚丙烯(polypropylene)、聚烯(polyolefin)材質)。使用具有短短的PVC管線入口及出口的過濾裝置，並不會導致DEHP的顯著溶解。3. 應經由孔徑不超過0.22um之管線內多微孔性濾膜給藥。4. 配製好的輸注溶液濃度在0.3 - 1.2 mg/mL，室溫25°°下安定性維持 27小時。5. 與鉑化合物並用時，應先使用Paclitaxel，再使用鉑化合物。 |
| IFORM | Formoxol inj 30mg/5mL (Paclitaxel) | IVD; | | | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 稀釋溶液與器具應使用玻璃、聚丙烯(polypropylene)、聚烯(polyolefin)材質，不可使用含DEHP的PVC塑膠材質。3. 配製好的輸注溶液濃度在0.3 - 1.2 mg/mL，室溫下安定性維持27小時。4. 注射前應先給予預防過敏的藥物。輸注開始的第一個小時應監測Vital Sign。5. 曾使用 Paclitaxel發生心臟傳導異常的病人，之後使用Paclitaxel期間應進行連續心電圖監測。6. 監測CBC。含有蓖麻油成分，容易造成病患過敏反應，施打時應由低速率開始調整，並注意病人反應。 |
| IFRA | Fragmin 10000 IU(Anti-Xa)/4mL(洗腎室專用) (Dalteparin) | IVD;SC; | | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | | 1. Dalteparin 不可經由肌肉注射給藥。2. 以溶解血栓或手術治療不適合之急性深部靜脈血栓與肺栓塞治療，Dalteparin可採每天一次或每天兩次的方式，經由皮下注射(SC)給藥。3. 預防血液透析(hemodialysis)與血液滲析(hemofiltration)期間的凝血，經由靜脈注射(IV)投與dalteparin。4. 本注射液可與裝於玻璃或塑膠容器中的生理食鹽水溶液(0.9% NaCl)或等張葡萄糖溶液(5%)混合。Fragmin與其他藥物的相容性至今尚未進行研究，因此不可與其他藥物混合使用。 |
| IFURO | Furosemide inj 20mg/2mL (Furosemide) | IM;IVD;IVPUSH; | | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【L/R】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | 20 to 40 mg per minute. | >=160mg時，以不超過4 mg/min之靜脈輸注速率給藥。 | 1. 本注射液為鹼性，勿與高度酸性液混合。2. 注液須新鮮配製，並在24小時內使用。3. 輸注速率參考資料來源:Lexidrug。 |
| IFYT | Fytosid inj 100mg/5mL (Etoposide) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | 給藥濃度 0.2-0.4mg/ml (Max 0.4mg/ml) ; 建議以30 ~ 60分鐘緩慢滴注 | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 配製好的輸注溶液濃度在 0.2 - 0.4 mg/mL，使用前應再次目視檢查是否有顆粒沉澱或變色。3. 輸注過快可能發生低血壓。4. 監測CBC、肝腎功能。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIG5P | Privigen TW inj 5gm/50mL (Human Immunoglobulin) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。 | | 初始輸注速率應為0.3 mL/kg/hr（注射約30分鐘）。若耐受性良好，輸注速率可逐漸增加。- 針對原發性免疫不全症病人: 輸注速率可逐漸增加至4.8 mL/kg/hr。若耐受性良好，輸注速率可逐漸增加至7.2 mL/kg/hr。- 針對慢性脫髓鞘多發性神經炎病人: 輸注速率可逐漸增加至4.8 mL/kg bw/hr。- 針對免疫性血小板缺乏紫斑症病人: 輸注速率可逐漸增加至2.4 mL/kg/hr。 | 1. 若溶液曾經冷凍，請勿使用。2. 不含抗微生物防腐劑，開瓶後必須立即使用。3. 本品嚴禁與生理食鹽水混合，僅可用於管路沖洗。 |
| IGCS | Gcsf 150mcg/0.6mL (Filgrastim) (Filgrastim) | IVD;SC; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | IV輸注時可使用D5W稀釋，濃度勿低於 5 mcg/mL。 | 1. IV輸注時可使用D5W稀釋，濃度勿低於 5 mcg/mL。 |
| IGEL | Gelofusine 500mL，4% (Succinylated Gelatin) | IVD; | | | | 500~1000 mL 滴注超過 1-3 hs | 此產品廠商未做相容性試驗，故不建議稀釋使用 |
| IGEMP | Gemphar inj 200mg (Gemcitabine) | IVD; | 0.9%生理食鹽水 5mL | 【N/S】可選 仿單建議。 | | | 1. 給藥時將配製好之溶液用0.9%生理食鹽水注射液進一步稀釋，最低濃度可低至0.1mg/mL。配製後之Gemphar為澄清、無色至淡麥稈色的溶液。2. 給藥前應以眼睛檢視溶液，若有異物或是變色現象，應將其丟棄。3. 依上述指示配製之Gemphar溶液在30℃以下可維持穩定24小時。配製後之溶液不可冷藏，因可能會形成結晶。4. 與點滴瓶或聚氯乙烯(PVC)材質之輸液袋及輸液套無不相容之情況發生。5. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。6. 監測CBC、肝腎功能。 |
| IGEN8 | Gentamycin inj 80mg/2mL (Gentamicin) | IH;IM;IMP;IRR; IVD;IVI;SCI; SUBCI; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【L/R】可選 。 | | 給藥濃度< 1 mg/mL (IV infuse over 30 minutes to 2 hours)。NeoFax建議：Infuse over a period of 30 to 120 minutes using a concentration of 2 mg/mL or 10 mg/mL. | 1. 監測體溫、CBC、肝腎功能、血鈣、血鉀、血鈉、血鎂、聽覺功能。2. 建議監測藥物血中濃度。 |
| IGLUC | Glucagen inj 1mg/1mL (Glucagon) | IM;IVP;IVPUSH; SC; | | | 使用在Hypoglycemia: 1 mg (1 unit), Children BW < 25 Kg: 0.5 mg (0.5 unit) | | 1. 配製好的溶液應立即使用，若有黏著狀或不容物質出現，應丟棄不用。2. 嚴重低血糖症病人若在給予Glucagon十分鐘內沒有反應，須以靜脈注射方式給予葡萄糖。3. Glucagon於診斷用途由IV給予，常見噁心、嘔吐的副作用。4. 若大量投予造成藥物過量，可能降低血鉀，必須加以監測，必要時給予校正治療。 |
| IGLY250 | Glycerol 10% inj 250mL (Glycerin + Fructose + Sodium Chloride) | IVD; | | | | [仿單]500mL滴注2~3小時。 | 1. 對於被懷疑為硬膜下、硬膜外血腫之患者，先處理出血源，並確認沒有再出血的疑慮，方可投與。2. 因含食鹽故對需要限制食鹽攝取的患者，投與時須注意。3. 因含果糖，故大量、急速投與時，應注意會產生乳酸酸中毒。4. 眼科手術中，因會引起尿意，故希望手術前先行排尿。5. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割Coring產生碎片。(20250116致電廠商詢問，此條項將於未來更新仿單刪除) |
| IGLYC | Glycopyrodyn inj 0.2 mg/1mL (Glycopyrrolate) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D10W】可選 。【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | | 1. 使用前應先檢查病人是否有任何心搏過速的現象，因為使用本藥品後有可能增加心跳速率。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGLYP8 | Glypressin inj 0.1 mg/mL，8.5mL (Terlipressin) | IVPUSH; | | 【D5W】可選 。 | IV slow bolus injection over 2 minutes. Flush the line after administration. | Total dose: 2 to 12 mg/day. A dose of teripressin in 5% dextrose 50mL，administered via IV pump. (備註:此用法非仿單核准，為歐洲醫藥管理局對發出的建議，用於第一型肝腎症候群，TFDA仍在評估中，此藥仿單不建議加入其他溶液，因此目前未設定IVD途徑。) | 1. 假使治療持續數天，必須監測尿量及血液電解質。為了避免注射部位局部壞死，一定要靜脈注射。2. [UpToDate] 由周邊或中央靜脈緩慢給藥（需超過2分鐘），給藥後請沖洗管路。3. 不可超過建議劑量(1.7 mg terlipressin /4 小時)，因為嚴重不良作用風險與劑量相關。治療期間發生心率過緩可使用atropine 治療。 |
| IGRA | Grantron inj 3mg/3mL (Granisetron) | IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】。【N/S】可選 。 | 推注時間至少超過30秒 | 稀釋於20-50mL輸注液，輸注時間>5分鐘 | |
| IHALA | Halaven inj 1mg/2mL (Eribulin) | IVD; | | 【N/S】仿單建議。 | | 可給予未稀釋或以100 mL 0.9% 氯化鈉溶液稀釋後的注射液。靜脈注射給藥時間為2至5分鐘。 | 不可以葡萄糖溶液稀釋或含葡萄糖溶液之靜脈注射管線給藥。 |
| IHEPA | HEPAC inj 25KIU/5mL (Heparin) | IA;IRR;IV;IVD; | | 【N/S】可選 仿單建議。 【H/S】可選 。 | | 輸注速率 10~20 u/mL/min | 1.未稀釋亦可使用 2.廠商建議使用稀釋亦為N/S |
| IHER | Herceptin inj 440mg (小劑量) (Trastuzumab) | IVD; | | 【N/S】可選 仿單建議。 | | | 1. 輸注溶液不可含葡萄糖。2. 第一次使用建議施打90分鐘，之後視病人耐受程度可縮短輸注時間至最短30 分鐘。3. 輸注時注意病人是否出現呼吸困難、周邊水腫、低血壓或其他急性過敏反應症狀。4. 監測CBC、肝腎功能。 |
| IHUMX | Humalog KwikPen 100U/mL 3mL (Insulin Lispro) | IVA;IVD; IVPUSH;SC; | | 【D5W】可選 仿單建議。 【N/S】可選 仿單建議。 | | 1. 溶於0.9% NaCl或 5% 葡萄糖液的 insulin lispro濃度介於 0.1 U/ml至1.0 U/ml可於室溫中維持穩定達48小時。2. 建議使用沒有輸注過任何藥物的輸注套件來輸注 insulin lispro。 | 1. 皮下注射應注射於上臂、大腿、臀部或腹部。2. 注射部位應更換，同一位置每個月注射不可超過一次。3. 應注意不要穿破血管，注射後請勿按揉注射部位。4. 開封後保存效期為28天。5. 每支注射筆應限於一位病人使用，即使針頭已經更換過。病人每次注射完後需要丟棄針頭。 |
| IHYD | Hydrocortisone inj 100mg (Hydrocortisone) | IM;IVD;IVPUSH; | 至多2mL 無菌注射用水或氯化鈉注射液。 | 【D5NS】可選 仿單建議。 【D5W】可選 仿單建議。 【N/S】可選 仿單建議。 | Administer undiluted over at least 30 seconds; for large doses (more than 500 mg), administer over 10 minutes. | Administer over 20 to 30 minutes. | 1. 緊急狀況初期最好使用靜脈注射。2. 高劑量療法應維持到病人穩定，通常不超過48到72小時。 |
| IIBU | Ibufor inj 400mg/100mL (Ibuprofen) | IVD; | | | | 成人: 輸注時間不得少於30 分鐘。6個月至17歲兒童: 輸注時間不得少於10分鐘。 | 1. 人在給予ibuprofen的治療前必須充足給予水分。2. 本品為即用型注射液，使用前無須額外稀釋。 |
| IIG25 | Gamunex-C inj 2.5 gm/25mL (Human Immunoglobulin) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。 | | 0.6-1.2 mL/kg/hr 的初始速率，經由靜脈輸注 30 分鐘。最高 4.8-8.4 mL/kg/hr。腎功能不全的病人必須先確認無體液缺乏情形;對於腎功能異常或血栓塞的高危險群病人，請以適當的最小輸注速率投與Gamunex-C。 | 1. 本藥品使用前應回溫至室溫或體溫。2. 容器一旦開封，必須立即輸注內容物。3. 輸注管路可使用5%的右旋-葡萄糖水溶液(D5W)或0.9%氯化鈉水溶液沖洗，且不可使用肝素沖洗。 |
| IIG3 | Human Immunoglobulin 3gm/50mL (Human Immunoglobulin G) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。 【N/S】可選 仿單建議。 | | 輸注速率< 4 mL/min;剛開始以 1 mL/min，持續15分鐘以上，之後速率可漸增，最高3-4 mL/min。 | 1. 本注射液可不稀釋直接靜脈輸注，也可用N/S或D5W稀釋後注射。2. 注射速率從 1 mL/min開始，持續15分鐘以上，之後速率可漸增，最高3-4 mL/min。3. 高齡病人及腎臟病病患應考慮使用較低速率給藥。4. 如發現注射液有混濁或沉澱，或是曾被冷凍過，切勿使用。5. 對於血液高度黏稠風險的病人，應評估其血液黏稠度。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIMF | Imfinzi inj 500mg/10mL (Durvalumab) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | 1. 從IMFINZI小瓶中抽取所需藥量，注入含有0.9%氯化鈉注射液或5%葡萄糖注射液的靜脈注射袋中。輕柔地翻轉以混合稀釋溶液。不要搖晃溶液。稀釋溶液的最終濃度應該在1 mg/mL和15 mg/mL之間。2. 靜脈輸注60分鐘。 | 1. 輸液須以具有無菌，低蛋白結合率之0.2或0.22微米(micron)管內過濾器的靜脈輸注管線輸注60分鐘。2. 不要通過同一條輸注管線同時給予其他藥物。3. 當IMFINZI於併用tremelimumab時，給予tremelimumab輸注60分鐘後，觀察60分鐘。隨後於同一天再另外輸注IMFINZI 60分鐘。4. 每次輸注使用單獨的輸注袋和過濾器。5. 當IMFINZI於併用含鉑化療時，先輸注IMFINZI，接著在同一天給予含鉑化療。6. 備好的輸液保存在2°C 至 8°C其物理和化學性質已證明可維持30 天穩定，而保存在室溫（不超過25°C）其物理和化學性質則已證明可維持24 小時穩定。但從微生物學的觀點，配製好的輸液應立即使用；如果無法立即使用，則輸液在使用前的存儲時間及條件由使用者負責，從配製起算，在2°C 至 8°C不應超過24 小時或在室溫下（最高25°C）不超過8小時，除非輸液是在受控和經過驗證的無菌條件下進行配製。 |
| IIMJU | Imjudo inj 300mg/15mL (Tremelimumab) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | Infuse over 60 minutes through an IV line containing a sterile, low-protein binding 0.2- or 0.22-micron filter. Administer all concomitant combination medications as separate IV infusions. Tremelimumab in combination with durvalumab: Administer tremelimumab first and observe patient for 60 minutes following completion of tremelimumab infusion, then administer durvalumab as a separate infusion on the same day. | 1. IMJUDO輸液須以具有無菌，低蛋白結合率之0.2或0.22微米(micron)管內過濾器的靜脈輸注管線輸注60分鐘。2. 給予IMJUDO輸注60分鐘後，觀察病人60分鐘。隨後於同一天再另外輸注IMFINZI 60分鐘。3. 每次輸注使用單獨的輸注袋和過濾器。4. 請勿以同一靜脈輸注管線併用其他藥物。5. IMJUDO加入0.9% 氯化鈉注射液或 5% 右旋葡萄糖注射液的靜脈輸液袋，最終濃度不超過10 毫克/毫升。劑量所需的稀釋液體積:300mg (> 30 kg)，最大稀釋液體積150mL。6. 若輸注液未立即使用需保存，從製備完到開始輸注的總時間應不超過2到8度C的冰箱中24小時；達30度C的室溫中24小時。 |
| IIRI | Irino IV infusion 100mg/5mL (Irinotecan) | IVD; | | | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 配製好的輸注溶液濃度在 0.12 - 2.8 mg/mL，室溫安定性維持 12 小時。3. 監測CBC、肝功能。4. 注意病人可能出現腹瀉的藥物副作用，尤其是65歲以上的老年人。若病人注射Irinotecan後發生延遲性腹瀉，應盡快聯絡醫師，給予適當治療。 |
| IISOP | Isoproternol inj 0.2 mg/1mL (Isoproterenol) | IM;IVD;IVPUSH; LI; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 溶解於20mL內等張溶液，徐緩注射於靜脈。 | 0.2-1mg溶解於200-500mL之等張溶液(Usual dosage range: 1 to 20 mcg/minute)。 | 1. 肌肉注射時，不要在同一部位反覆注射，並避開神經行走部位。如發生抱怨刺痛或血液逆流時，應立即將針頭拔起，更換注射部位。2. 與如Sodium Bicarbonate的Alkali劑混合會即時變成紅褐色，應避開混合。 |
| IIXE | Ixempra inj 15mg (2mg/mL) (Ixabepilone) | IVD; | 使用包裝內附8mL稀釋液溶解乾粉，稀釋液從冰箱取出須靜置30分鐘，回到室溫後使用。 | 【L/R】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | | 1.使用0.9% Normal saline作為點滴液時，必須借由加入2mEq的碳酸氫鈉注射液將pH值調整成6.0-9.0之間. 2.本藥品需裝於不含DEHP的包裝中. 3.為容許抽取損失，本品包裝內含16mg Ixabepilone，加入8mL稀釋液後，配製成濃度2mg/mL. 4.配製本藥時，將8mL稀釋液抽取並注入藥瓶中，已輕輕旋轉及翻轉藥瓶的方式直到完全溶解. |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK2P | Potassium Phosphate inj 20mL (K2HPO4+KH2PO4) | IVD; | | 【N/S】可選 。 | | For adult patients with severe symptomatic hypophosphatemia (ie, <1.5 mg/dL), may administer at rates up to 15 mmol phosphate/hour (this rate will deliver potassium at 22.5 mEq/hour). Potassium infusion rates >10 mEq/hour should be administered via central line (minimizes burning and phlebitis). ECG monitoring is recommended for potassium infusions >10 mEq/hour in adults or >0.5 mEq/kg/hour in children. In patients with renal dysfunction and/or less severe hypophosphatemia, slower administration rates (eg, over 4 to 6 hours) or oral repletion is recommended. | 1. 本品為高濃度鉀離子溶液，須稀釋後使用，限藥劑科用於製劑調配。2. 每 mL含 phosphate : 3 mmole, potassium : 4.4 mEq |
| IKAD1 | Kadcyla inj 100mg (小劑量) (Trastuzumab Emtansine) | IVD; | | | | | 1. 輸注溶液不可含葡萄糖。2. 第一次使用建議施打90分鐘，之後視病人耐受程度可縮短輸注時間至最短30 分鐘。請使用0.2-0.22微米、不吸附蛋白質的管線為 polyethersulfone (PES)過濾器。3. 溶液配置後應立即使用，冷藏於2-8℃最多儲存24小時。4. 輸注時注意病人是否出現呼吸困難、周邊水腫、低血壓或其他急性過敏反應症狀。5. 監測CBC、肝腎功能。 |
| IKAT | Katimin"1" inj 10mg/1mL (Phytonadione) | IM;IVP;IVPUSH; | | | Slow IV，推注速率 < 1mg/min | | |
| IKCL | KCl 10mEq in NaCl 0.9% inj 500mL (Potassium Chloride) | IVD; | | | | | 1.使用期間應嚴密監測病患血鉀濃度與心電圖。2.與ACE抑制劑併用可能引起高血鉀症。3.與保鉀型利尿劑併用可能引起嚴重高血鉀症、心律不整與心跳停止。4.鉀離子排除功能受損或輸注太快時，可能發生致命性高血鉀症。 |
| IKCL1 | KCl 15% (限添加用) inj 10mL (Potassium Chloride) | IVA;IVD; | | 【D5W】可選 。【H/S】可選 。 | | | 1. 本品為高濃度鉀離子溶液，須稀釋後使用，限藥劑科用於製劑調配。2. KCl製劑濃度 >= 0.1 mEq/mL時不可從周邊給藥。請確認病人有中央靜脈導管(Central venous catheter, CVC)，並在處方箋註明由中央靜脈導管給藥。 |
| IKCL2 | KCl 20mEq in NaCl 0.9% inj 500mL (Potassium Chloride) | IVD; | | | | | 1.使用期間應嚴密監測病患血鉀濃度與心電圖。2.與ACE抑制劑併用可能引起高血鉀症。3.與保鉀型利尿劑併用可能引起嚴重高血鉀症、心律不整與心跳停止。4.鉀離子排除功能受損或輸注太快時，可能發生致命性高血鉀症。 |
| IKCL5S | KCl 20mEq in D5W inj 500mL (Potassium Chloride) | IVD; | | | | | |
| IKCL7S | KCl 20mEq in D5NS inj 500mL (Potassium Chloride) | IVD; | | | | | 1.使用期間應嚴密監測病患血鉀濃度與心電圖。2.與ACE抑制劑併用可能引起高血鉀症。3.與保鉀型利尿劑併用可能引起嚴重高血鉀症、心律不整與心跳停止。4.鉀離子排除功能受損或輸注太快時，可能發生致命性高血鉀症。 |
| IKCL8 | KCl 20mEq in NaCl 0.9% inj 100mL (軟袋) (Potassium Chloride) | CVC; | | | | | 1.使用期間應嚴密監測病患血鉀濃度與心電圖。2.與ACE抑制劑併用可能引起高血鉀症。3.與保鉀型利尿劑併用可能引起嚴重高血鉀症、心律不整與心跳停止。4.鉀離子排除功能受損或輸注太快時，可能發生致命性高血鉀症。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKCL8S | 1.49% KCl (20mEq) in NaCl 0.9% inj 100mL (Potassium Chloride) | CVC; | | | | IV Adult Serum K <2 mEq/L: 20-40 mEq/hr, with ECG monitoring. Max: 400 mEq/day. Serum K >2.5 mEq/L: 10-15 mEq/hr; max: 200 mEq/day. Intermittent IV Children 0.5-1 mEq/kg/dose; infuse at 0.3-0.5 mEq/kg/hr; MAX: 1 mEq/kg/hr & 30 mEq/dose; MAX: 3 mEq/kg/day or 40 mEq/m2/day. Central line infusion: maximum rate 40 mEq/hr. peripheral IV infusion: maximum rate 10 mEq/hr. | 1.使用期間應嚴密監測病患血鉀濃度與心電圖。2.與ACE抑制劑併用可能引起高血鉀症。3.與保鉀型利尿劑併用可能引起嚴重高血鉀症、心律不整與心跳停止。4.鉀離子排除功能受損或輸注太快時，可能發生致命性高血鉀症。 |
| IKCL9 | KCl 20mEq in D5W inj 500mL (軟袋) (Potassium Chloride) | IVD; | | | | | |
| IKEP | Keppra inj 500mg/5mL (Levetiracetam) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | 必需稀釋到至少100 mL的相容稀釋液後，建議以15分鐘緩慢滴注。 | 1. Keppra Inj 500mg/5mL僅靜脈輸注使用，建議劑量必需稀釋到至少100 mL的相容稀釋液中，以15分鐘的靜脈輸注時間給藥。2.本藥為單次使用，未用完的溶液不應保留。經稀釋後從微生物學的觀點應立即使用，若無法立即使用通常2-8°C不超過24小時，除非稀釋步驟以無菌環境下進行。經稀釋後的化學穩定與下列稀釋液(D5W, N/S, L/R)在室溫15-25°C下PVC袋中達24小時。 |
| IKET | Ketalar inj 500mg/10mL (Ketamine) | IM;IVD;IVPUSH; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | 建議ketamine注射應緩慢進行(以60秒)。 | 以無菌操作方式取10毫升(50 mg/ml小瓶)的ketamine置入500毫升5%的葡萄糖注射液或0.9%的氯化鈉注射液中，混合均勻。如此可得每毫升含1毫克(1 mg/ml)的ketamine的溶液。用5%葡萄糖或0.9%氯化鈉注射液配製成的ketamine 1 mg/ml溶液，在24小時內可保持穩定。倘若需要限制液體量，可將ketamine加至250毫升上述輸液中，配製成每毫升含2毫克(2 mg/ml)的溶液。 | 1. 巴比妥酸鹽類由於與ketamine HCl配伍禁忌會發生化學沉澱現象，故二者不能使用同一注射針筒。2. 倘若ketamine要與diazepam併用，這二種藥品應分開施打。不可在同一支注射針筒或點滴瓶內混合ketamine和diazepam。3. 單一劑量的容器。打開後：從微生物學的觀點來看，除非打開的方法排除微生物污染的風險，否則產品打開後應立即使用。給藥後丟棄未使用完的產品。 |
| IKETO | Keto針劑 30mg/1mL (Ketorolac) | IM;IV;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | 推注時間至少 15秒 | | 1. IM: 緩慢及深部投予 2. 仿單警語：(1)Ketorolac不可用於退燒，且禁止使用於產科相關止痛。(2)臺灣曾有病患使用Ketorolac導致過敏性休克，甚至死亡之案例發生，應小心使用本藥品。(3)使用注射劑型之Ketorolac成分藥品時，需有急救設備備用，注射後半小時內應有人監控病患之安全性。 |
| IKEY1 | Keytruda inj 100mg/4mL (Pembrolizumab) | IVD; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | IV infusion over 30 minutes. | 製備: 1. 抽取需要的藥量，注入0.9%氯化鈉注射液或5%葡萄糖注射液的靜脈輸注袋中。(輕轉的方式混勻溶液)。2. 溶液的最終濃度應為1毫克/毫升至10毫克/毫升之間。6. 稀釋後可存放室溫，但不可超過6小時。(包括於室溫下，泡製後之藥瓶的存放時間、IV袋中之輸注溶液的存放時間、以及輸注所需要的時間) |
| IKISU | Kisunla inj 350mg/20mL (Donanemab) | IVD; | | 【N/S】可選 仿單建議。 | | 稀釋至濃度4mg/mL至10mg/mL，輸注時間約30分鐘。 | 1. 稀釋後，可冷藏儲存於2°C至8°C最多72小時，或於室溫下(20°C至25°C)最多12小時。儲存時間包括輸注時間。2. 輸注前，若稀釋溶液曾經冷藏儲存，請讓稀釋溶液回溫至室溫。3. 輸注結束時僅可使用0.9%氯化鈉注射液沖洗管路。4. 輸注後觀察病人最少30分鐘，以評估是否發生輸注反應及過敏反應 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILAS | Lasix 針劑 20mg/2mL (Furosemide) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | 推注時間至少 5分鐘 | 滴注速率 <4mg/min，稀釋後pH值須維持在弱鹼 (7-10之間) | 1.pH>5.5時IVD < 4mg/min 2.未稀釋亦可使用 3.避光使用，溶液變色即不可使用 |
| ILATO | Laston inj 30mg/1mL (Ketorolac) | IM;IVD;IVPUSH; | | 【N/S】可選 。 | administer over 15 seconds | 15mg or 30mg in 0.9% NaCl 50mL IVD infused over 30 minutes | 1. 靜脈注射 (bolus) 時間不得低於15秒，肌肉注射應採緩慢及深部投與。2. 禁用於椎管內與硬膜外給藥。 |
| ILEV2 | Norepinephrine inj 4mg/4mL (Norepinephrine) | IVD; | | 【D5NS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【L/R】可選 。 | | 滴注速率為 2-4 mcg/min。IV infusion: 4 mg in 250 mL (concentration: 16 mcg/mL) or 8 mg in 250 mL (concentration: 32 mcg/mL). | 1.Norepinephrine使用前應稀釋於含葡萄糖的注射液。2.本品儘可能注射於大靜脈，特別是肘前靜脈，因為長時間的血管收縮而造成上層皮膚壞死的危險，使用本方式極少有之。也有專家建議由股靜脈注射。應避免使用導管tie-in 技術(catheter tie-in technique)，因為管子周圍血流阻礙會造成血行停滯，並增加藥物的局部濃度。通常下肢產生閉塞性血管疾病的可能性較上肢大。因此年老患者或曾患類似疾病之患者，要避免腿部靜脈給藥，踝靜脈給藥曾有下肢末端產生壞疽的報告。 |
| ILFT | Lofatin inj 2gm (Cefoxitin) | IM;IVD;IVPUSH; | [仿單] 加蒸餾水、生理食鹽水行靜脈或點滴注射。[Micromedex] For IV bolus，reconstitute 2-g vial with 10 or 20 mL sterile water for injection. For IV infusion，reconstitute 2-g vial with 10 or 20 mL sterile water for injection，bacteriostatic water for injection, NS，or D5W. | 【N/S】可選 仿單建議。 | [Micromedex] IV bolus >3-5 minutes. May give 1-g doses over 2 minutes，and 2-g doses over 5 minutes. | [Micromedex] Reconstituted vials may be further diluted in 50-100 mL of NS，D5W，or D10W Injection [UpToDate] intermittent infusion over 10-60 minutes | [仿單] 1. 靜脈內大量投與會引起血管痛、血栓靜脈炎，預防方法須注意注射液之調製，注射部位及注射方法，減慢注射速度。2. 乾粉溶解後須儘速使用，稀釋於輸注液後若儲存於25°C以下可保存24小時，在2-8°C可保存5天以內使用。 |
| ILIPD | Lipo-Dox inj 20mg (自費用) (Doxorubicin Liposome) | IVD; | | 【D5W】仿單建議。 | | 給藥劑量在90mg以下：以250 ml之5%葡萄糖溶液(Dextrose 5% in Water)稀釋 給藥劑量在90mg(含)以上：以500 ml之5%葡萄糖溶液稀釋。起始劑量的輸注速率應不超過1 mg/min。若無輸注不良反應，剩餘藥物可以60分鐘輸注完畢。 | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 監測CBC、肝腎功能、尿酸與血中電解質濃度。 |
| ILIPD1 | Lipo-Dox inj 20mg (健保用) (Doxorubicin Liposome) | IVD; | | | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 監測CBC、肝腎功能、尿酸與血中電解質濃度。3.Pegylatedliposomal doxorubicin的累計劑量到450mg/m2時，需作左心室功能評估，並且在每增加100mg/m2給藥前再次評估. 450-600mg/m2並不會增加心臟毒性的危險性 |
| ILIPOAB | Lipo-AB inj 50mg (Amphotericin B Liposome) | IVD; | 於每瓶Lipo-AB加入12 mL無菌注射用水，使每mL含4 mg的Amphotericin B。注意：請勿與鹽液調和或加入鹽液或與其他藥物混合。若以非上述建議之溶液配製或其溶液含有抑菌劑，可能會造成Amphotericin B Liposome for Injection的沉澱。 | 【D5W】可選 仿單建議。 | | 建議注射時間超過120分鐘。若病人的耐受性良好，其輸注時間可減至約60分鐘。 | 1. 加入注射用水後立即用力搖晃30秒。2. 稀釋請裝上5 micron過濾器於針管上，注入含正確量的5% Dextrose溶液，稀釋至1.0-2.0 mg/ml之濃度，對於幼兒及較小孩童其濃度可減至0.2-0.5 mg/ml。3. 已用無菌注射用水溶解的濃縮液在2°C-8°C下可存放24小時。以5% Dextrose 溶液稀釋之Amphotericin B Liposome for Injection需於6小時內用完。4. 不同的amphotericin產品 (脫氧膽酸鈉鹽、微脂粒、脂化複合物)在藥效學、藥物動力學和劑量方面並不相等，不可交替使用。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILQB | Leqembi inj 200mg/2mL (Lecanemab) | IVD; | | 【N/S】可選 仿單建議。 | | 抽取所需的lecanemab，加入250 mL 0.9%氯化鈉注射液，輸注約1小時。 | 1. 輸注前，讓lecanemab稀釋溶液回溫至室溫。2. 考慮在後續給藥時預防性給予抗組織胺、非類固醇抗發炎藥或皮質類固醇。3. 稀釋後建議立即使用。如果不立即給藥，可在2°C至8°C冷藏保存最多4小時，或在室溫至30°C保存最多4小時。請勿冷凍。 |
| IMAB1 | Mabthera inj 100mg/10mL (小劑量) (Rituximab) | IVD; | | | | | 1. 第一次使用：給藥速率建議從50 mg/小時開始，之後視病人耐受程度可每30 分鐘提高50 mg/小時，最大速率不可超過400 mg/小時。2. 第二次以後使用：給藥速率建議從100 mg/小時開始，之後可每30 分鐘提高100 mg/小時，最大速率不可超過 400 mg/小時。若病人耐受程度良好，快速給藥之給藥時間應> 60 分鐘。3. 配製好的輸注溶液濃度約1 -4 mg/mL，室溫安定性維持12 小時。4.患有心律不整、心絞痛、肺疾患的病人，輸注時加強監測心肺功能。5. 監測CBC、腎功能。 |
| IMAB5 | MABTHERA infusion 500mg/50mL (Rituximab) | IVD; | | | | | 1. 第一次使用：給藥速率建議從50 mg/小時開始，之後視病人耐受程度可每30 分鐘提高50 mg/小時，最大速率不可超過400 mg/小時。2. 第二次以後使用：給藥速率建議從100 mg/小時開始，之後可每30 分鐘提高100 mg/小時，最大速率不可超過 400 mg/小時。若病人耐受程度良好，快速給藥之給藥時間應> 60 分鐘。3. 配製好的輸注溶液濃度約1 -4 mg/mL，室溫安定性維持12 小時。4.患有心律不整、心絞痛、肺疾患的病人，輸注時加強監測心肺功能。5. 監測CBC、腎功能。 |
| IMAG2 | Mg Sulfate 10% inj 200mL (Magnesium Sulfate) | IH;IM;IVD;IVP; IVPUSH; | D5W，N/S，L/R | | 輸注速率: < 1.5 mL/min, Severe hypomagnesemia (<1 mg/dL) with polymorphic VT (including torsade de pointes): IV push 1 to 2 g (10-20 mL) | 輸注速率: < 1.5 mL/min | 1.有腎功能障害之患者；高鎂血症患者；腸內有寄生蟲之小孩患者及有心臟疾病患者必須審慎投與，以免造成危險。2.妊娠婦投與時，由於硫酸鎂很容易通過胎盤，曾經有引起極少數新生兒之高鎂血症，故應小心投與。3.本劑與含有磺胺劑、鹼性碳酸鹽、碳酸氫鹽、酒石酸鹽、可溶性磷酸鹽、砷酸鹽、溴化鉀、溴化銨等製劑一起混合使用時會有沉澱產生，配合時必須注意。4.本劑若與其他全靜脈營養輸注液調配混合後，請儘速使用。5.硫酸鎂中毒時常引起呼吸停止，應隨時注意血中濃度並給予鈣劑注射解毒。 |
| IMENO | Menocik inj 100mg (Minocycline) | IPLE;IVD; | IV: Reconstitute with 5 mL sterile water for 100 mg injection. | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | Infuse over 60 minutes; avoid rapid administration. Reconstitute with 5 mL sterile water for injection and further dilute immediately in 100 to 1000 mL of NS，dextrose injection，or dextrose and sodium chloride injection. | 請勿用任何含鈣溶液稀釋，因為有沉澱風險，在中性和鹼性溶液中更容易發生。配製成溶液後可在室溫保存24小時，不影響其力價，但稀釋後需立刻使用。延長靜脈注射的療程可能會導致血栓性靜脈炎。 |
| IMEP2 | (美平)Mepem inj 0.25 gm (Meropenem) | IVD; | IVD: 5mL N/S | 【N/S】可選 。 | | 通常0.25g-2g用100mL以上的生理食鹽水溶解後使用，即2.5-20mg/mL或更小濃度，建議以>30分鐘緩慢滴注。 | 1. 監測體溫、CBC、肝腎功能，注意是否有肌肉震顫或癲癇發作徵狀。2. 給藥後第3 ~ 5天應特別觀察皮疹等不良反應。3. 溶解後應立即使用。以等張食鹽水溶解後，室溫25℃可保存6小時，5℃可保存24小時。詳細安定性數據請參見藥物仿單。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMET5 | Mepron inj 40mg (Methylprednisolone) | IM;IVD;IVPUSH; | 40mg添加1-2mL注射用水調配注射液 | 【D5NS】可選 仿單建議。<br>【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | administer slowly over 1 minute | Reconstitute 40mg with 1-2mL water for injection. Dilute with 5% dextrose，0.9% sodium chloride or 5% dextrose and 0.9% sodium chloride injection. [UpToDate] Infused >15-60 minutes. For doses >250 mg，infused >30-60 minutes. [Micromedex] Adult: high-dose therapy (30 mg/kg) infused >30 minutes; Pediatric: high doses (15-30 mg/kg or 500-1000 mg/dose) can be diluted to a concentration of 2.5-20 mg/mL in D5W，NS and infused over 30-120 minutes. | 已調配好的溶液應冷藏並應於48 小時內用完。 |
| IMETE2 | Methylergonovine inj 0.2mg/1mL (Methylergonovine) | IM;IVPUSH;SC; | | | administer over 1 minute | | 1.發生子宮收縮作用時間：皮下或肌肉注射後3-5分鐘內；靜脈注射後0.5-1分鐘內。2.Slowly IV over >60 seconds with careful monitoring of blood pressure. Do not routinely administer IV because of the possibility of inducing sudden hypertension and cerebrovascular accident; only consider IV administration during life-threatening situations. |
| IMETR5 | Metronidazole inj 500mg/100mL (Metronidazole) | IVD; | | | | Slow IV over 1 hour. Do not mix with other solutions or drugs. | 1. 本品需置於25oC以下避光處所，並避免冷凍。2. 本品不得與鋁製品(如:針、套管等)接觸。3. 本品應緩慢靜脈輸注1小時，不需稀釋，禁止與其他溶液同時使用。4. 使用前不須稀釋或加緩衝劑。 |
| IMETY | Methycobal inj 500mcg/1mL (Mecobalamin) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【N/S】可選 。 | | in 50mL N/S run 10 mins，給藥時請避光。[202508血腫科吳鴻誠醫師MEMO] | 1.IM is the preferred route of administration. IV administration is not recommended because the drug is excreted more rapidly and almost all of the cyanocobalamin is lost in the urine. 2.The medicine is light sensitive，so protection from light is recommended. |
| IMIA | Miacalcic inj 50 IU/1mL (Salmon Calcitonin) | IM;IVD;SC; | | 【N/S】可選 仿單建議。 | | 高血鈣危象時可能採用靜脈輸注，劑量 5-10 U/Kg/day 加入500 mL N/S，作6小時以上靜脈輸注，或將日劑量均分成2-4次慢速靜脈注射。 | 1. 注射量 >2 mL建議採肌肉注射，並於不同部位施打。。2. 高血鈣危象時可能採用靜脈輸注，劑量5-10 U/Kg/day 加入500 mL N/S，作6小時以上靜脈輸注，或將日劑量均分成2-4次慢速靜脈注射。 |
| IMIL | Millisrol inj 5mg/10mL (Nitroglycerin) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【L/R】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。<br>【D5NS】可選 。 | | 稀釋成0.005 ~ 0.05% (50 ~ 500 mcg/mL)，IV infusion rate: 0.05 - 5 mcg/kg/min依適應症不同，應使用玻璃或non-PVC材質。 | 1. 應使用玻璃或non-PVC材質 2. 點滴速度較低及輸注管較長，皆會增加輸注時藥品被吸附的比率。3. 使用本劑應監測血壓。 |
| IMIR | Mircera inj 50mcg/0.3mL (Methoxy Polyethylene Glycol-Epoetin β) | IV;SC; | | | | | Intravenous: Inject into the venous port of the hemodialysis tubing. SC: Inject into the outer aspect of the upper arms，abdomen (except for 2 inches around the navel)，or front aspect of the middle thighs. Do not inject into an area that has scars or stretch marks or is tender，red，bruised，or hard. Rotate injection sites with each injection to prevent soreness. |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMIT3 | Mitonco inj 10mg (Mitomycin C) | IA;IP;IPLE;IRR; IVD; | 每2mg (力價)Mitomycin C用5mL Normal Saline加以溶解。 | 【N/S】可選 仿單建議。 | | (1) 靜脈注射可能會引起血管痛、靜脈炎、血栓等，因此對注射部位，注射方法等須十分注意，注射速度應緩慢。(2) 靜脈注射而藥液漏出血管外時，可能會引起注射部位之硬結、壞死等，因此應小心注射，使藥液不漏出血管外。(3) 因動脈注射可能導致動脈周圍皮膚異常，如疼痛、發紅、紅斑、水泡、糜爛、潰瘍等皮膚疾病，甚至引起皮膚、肌肉壞死。如出現這種症狀時，應立即中止投與，做適當處置。 | 1. 本品開封、調劑後儲存於原包裝25℃以下環境，可存放24 小時。2. Mitomycin C的藥效可能因溶解液的pH 值太低而減弱，藥液製成後儘快使用，避免與低pH值的注射液混合。3. 注射液之調製法: 每2mg (力價)Mitomycin C用5mL Normal Saline加以溶解。 |
| IMORP | Morphine inj 10mg/1mL (Morphine) | IM;IVD;IVP; IVPUSH;SC; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 推注時間至少4-5分鐘 | 起始劑量: 每3-4小時2.0-5mg，持續輸注: 0.8-10mg/hr；用呼吸器的病患(以70kg計)起始劑量: 每1-2小時0.7-10mg，持續輸注: 5-35mg/hr | 1. IV給藥濃度0.5-3mg/mL，緩慢注射4-5分鐘。 |
| IMTX2 | Methotrexate inj 50mg/2mL (Methotrexate) | IM;IVD; | | 【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 監測CBC、肝腎功能。 |
| IMUT | Mutonpain inj 10mg/1mL (Nalbuphine) | IM;IVD;IVPUSH; SC; | | 【D10W】可選 。【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | 靜脈注射時間需超過10-15分鐘(降低劑量或延長注射時間可減少副作用) | 仿單並無稀釋濃度或注射速率建議，2021/04/13廠商回覆：因本藥可不經稀釋直接使用，故無配製濃度與輸注速率建議，請留意病患臨床反應，且降低流速或濃度可減少副作用。 | 仿單無建議的稀釋液，2021/04/13廠商回覆可依參考書Handbook on Injectable Drugs，在D5W，D10W，Normal Saline，Ringer's solution四種稀釋溶液中可相容且安定48小時. |
| IMV13 | Lyo-Povigent inj 4mL (13種成份) (Multivitamin) | IVA; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | 本劑PART Ⅰ、PART Ⅱ混合溶解後，加入高熱量輸注液後稀釋使用 | 1.脂溶性維生素的滲透壓很高，仿單建議「本劑避免單獨投與，及末梢靜脈內投與」。廠商建議：如果需週邊施打(滲透壓 < 300 mOsm/L)，每劑4mL請使用500-1000 mL以上的溶劑稀釋。溶劑可選用N/S或D5W。2. 仿單建議「本劑PART Ⅰ，PART Ⅱ混合溶解後，應迅速加入高熱量輸液中稀釋後才能使用，通常應在12小時內使用完。為防止維他命被光分解，因此在貯存，溶解使用時，均應避光。」廠商建議：混合後未使用完畢，冷藏3天。 |
| IMYC | Mycamine inj 50mg (Micafungin) | IVD; | IVD: 5mL N/S，D5W(需減少泡沫形成) | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | 給藥濃度0.5~1.5mg/mL，建議滴注1小時以上 | 本品配製後應避光，並可儲存在原小瓶內，室溫25℃(77℉)下最多保存24小時。 |
| IMYF | Myfungin inj 50mg (Micafungin) | IVD; | 將5 mL D5W或N/S加入Micafungin小瓶中，輕輕搖動小瓶，以減少過多泡沫的形成。 | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | 1. 輸注時間大約1小時，較為快速的輸注可能會使組織胺媒介的反應較常發生。2. 大於1.5 mg/mL的濃度應由中央靜脈靜脈導管給藥。 | 稀釋的輸液應避光，室溫25°C下最多保存24小時，不需要遮蓋點滴腔與點滴管。 |
| INAL | Naloxone inj 0.4 mg/1mL (Naloxone) | IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | IV push: Administer over 30 seconds as undiluted preparation or administer as diluted preparation slow IV push by diluting 0.4 mg (1 mL) ampul with 9 mL of normal saline for a total volume of 10 mL to achieve a concentration of 0.04 mg/mL. | 2 mg naloxone以500mL N/S，D5W稀釋為0.004 mg/mL，依病人臨床反應調整給藥速率 | 1. IV infusion：2 mg naloxone以500 mL N/S 或 5% Dextrose solution稀釋為0.004 mg/mL，依病人臨床反應調整給藥速率。 |
| INEP | Nephrosteril 7% inj 250mL (Amino Acids) | IVD; | | | | | 1. 每日每公斤體重最高1.5公克胺基酸，滴速不能超過每分鐘20滴。滴速過快可能造成噁心、寒顫和嘔吐的症狀。2. 未接受血液透析治療的急性和慢性腎功能不足病人，每日每公斤體重最高0.5公克胺基酸。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INESP | NESP inj 20mcg(洗腎用) (Darbepoetin alfa) | IV;SC; | | | | | |
| INIM | Nimotop針劑10mg/50mL (Nimodipine) | CVC;IVD; | | 【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | | 起始速率:15 mcg/kg/hr輸注速率 < 2mg/hr (本藥應與下列相容溶液以一比四比例經由三向活塞給予，包括D5W、0.9% NaCl、Lactated Ringer's solution、含有鎂的乳酸鹽林格氏液、dextran40 solution、HAESR poly (O-2-hydroxyethyl) starch 6%、甘露醇(mannitol)、人類白蛋白(human albumin)以及血液。) | 1. Nimotop輸注液需使用輸注幫浦以連續靜脈輸注經由中央靜脈導管(central catheter) 注入體內。2. 由於藥品的有效成分會被聚氯乙烯(PVC)吸附，因此只能使用聚乙烯(PE)的輸注管。3. 藥品勿直接加入點滴，應由三向活塞(three-way stopcock)與相容溶液以一比四的比例一同給予。 |
| INIMB | Nimbex inj 10mg/5mL (Cisatracurium) | IVD;IVPUSH; | | 【D2.5HS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | 在5到10 秒內快速給予。 | 建議可給予一個3 mcg/kg/min (0.18 mg/kg/hr)的點滴起始速率。在神經肌肉阻斷作用開始達穩定狀態時，使用1到2 mcg/kg/min (0.06到0.12 mg/kg/hr)的點滴速率。 | 1.僅供靜脈給藥。2.給藥濃度 0.1-2.0 mg/mL。3.本品需冷藏避光貯存4.不可與鹼性溶液混合 5.以小靜脈做為注射處時，應使用適當的靜脈輸注液(如0.9%氯化鈉靜脈注射液)將Nimbex注射劑洗入靜脈內. |
| INOV1 | Novo Seven RT 1mg (Eptacog alfa) | IVD;IVP; IVPUSH; | 使用產品所附溶液稀釋 | | 緩慢地進行靜脈注射，注射時間2-5分鐘為宜 | 緩慢地進行靜脈注射，注射時間2-5分鐘為宜 | 1.限用專用注射溶劑，不可與其他輸注液混合2.緩慢地進行靜脈注射，注射時間2-5分鐘為宜，不可以點滴方式給藥。 |
| INOVX | NovoRapid FlexPen 100U/mL 3mL (Insulin Aspart) | IVA;IVD;SC; | | 【N/S】可選 。 | | 使用靜脈注射時，使用 polypropylene 輸注袋，並且以 0.9% sodium chloride 或含有 40 mmol/l potassium chloride 之 5%或 10% dextrose 為輸注溶液配製濃度0.05 U/ml 到 1.0 U/ml 的 NovoRapidR100 U/ml 之輸注系統，在室溫下可維持安定達 24 小時。雖然隨著時間能保持穩定，但有少量的胰島素在一開始會被輸注袋所吸收。在輸注過程中，血糖的監控是必需的。 | |
| IOCI | Ocillina inj 500mg (Oxacillin) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | IM: 2.7 mL D/W IV: 5mL D/W，N/S | 【D5NS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。 | 推注速率 < 100 mg/分鐘，建議推注> 10分鐘 | 給藥濃度0.5~40 mg/mL，建議輸注> 30分鐘 | 注射前檢查病患是否有Penicillin過敏史 1.注射速率太快可能造成癌攣性癲癇。2.老年人應減慢給藥速率，避免發生血栓性靜脈炎。3.監測體溫、CBC、血球分化計數、肝腎功能。4.特殊族群: 年長者、肝、腎功能受損者不需調整劑量。5. 濃度0.5~2 mg/mL 的藥物安定性: 在6小時會減少10%以下的活性。 |
| IOGI | Ogivri inj 440 mg (健保) (Trastuzumab) | IVD; | 包裝中的稀釋液(20 毫升含1.1%苯甲醇的制菌注射用水)。 | | | 抽取病患藥物量後加到裝有0.9%氯化鈉250 毫升的注射袋中稀釋，起始劑量建議靜脈輸注90 分鐘。維持劑量時若病人對先前劑量的耐受力佳，可輸注30分鐘即可。 | 1.配製的說明: 使用無菌針筒，慢慢注入20 毫升制菌注射用水於含凍晶Ogivri 的小瓶，直接注射至凍晶塊。再溫和地轉動小瓶幫助調配，不要搖晃。2.使用包裝中所提供的制菌注射用水混合後的配製後溶液，冷藏在2-8℃可以維持28 天的安定。如果使用滅菌水配製則僅維持24 小時安定，之後必須丟棄。3.配製於裝有0.9%氯化鈉溶液的注射用袋中，在2-8℃下其物化性質可維持穩定24 小時。4.禁止使用5%的dextrose 溶液，因為會引起蛋白質凝集。 |
| IOGIS | Ogivri inj 440 mg (絕對自費) (Trastuzumab) | IVD; | 包裝中的稀釋液(20 毫升含1.1%苯甲醇的制菌注射用水)。 | 【N/S】可選 仿單建議。 | | 抽取病患藥物量後加到裝有0.9%氯化鈉250 毫升的注射袋中稀釋，起始劑量建議靜脈輸注90 分鐘。維持劑量時若病人對先前劑量的耐受力佳，可輸注30分鐘即可。 | 1.配製的說明: 使用無菌針筒，慢慢注入20 毫升制菌注射用水於含凍晶Ogivri 的小瓶，直接注射至凍晶塊。再溫和地轉動小瓶幫助調配，不要搖晃。2.使用包裝中所提供的制菌注射用水混合後的配製後溶液，冷藏在2-8℃可以維持28 天的安定。如果使用滅菌水配製則僅維持24 小時安定，之後必須丟棄。3.配製於裝有0.9%氯化鈉溶液的注射用袋中，在2-8℃下其物化性質可維持穩定24 小時。4.禁止使用5%的dextrose 溶液，因為會引起蛋白質凝集。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOKM | OKmilon inj 0.25 mg/5mL (Palonosetron) | IVD;IVPUSH; | | 【N/S】可選 。 | 成人：靜脈注射超過30秒 | 兒童與青少年(1 個月大至 17 歲)：單一劑量20mcg/kg(最大劑量不可超過1500 mcg)，靜脈輸注時間須超過15分鐘。 | 1.本品僅供靜脈注射用，不應與其他藥物混合。投與本品前後均須用生理食鹽水沖洗輸注管線。2.廠商提供支安定性資料 本品3AMP(15mL)稀釋於250mL 0.9% Sodium Chloride及 2AMP(10mL)稀釋於90mL 0.9% Sodium Chloride皆有4小時的安定性。 |
| IOLI3 | Oliclinomel N4-550E Emulsion 1500mL (Amino Acid + Dextrose + Electrolytes + Lipid) | IVD; | | | | | 1.此輸注乳液最大輸注速率勿超過3毫升/公斤/小時。2.若有任何症狀或跡象顯示過敏反應(如：發燒、顫抖、皮疹或呼吸困難，應立即停止輸注。3.本輸注乳液絕對不可於輸血時使用相同的輸注導管裝置，因為可能導致假性凝血跡象。4.本產品需在三袋液體充分混合後方可使用，限單次使用。 |
| IOMN1 | Omnipaque 350mg I/mL，100mL (Iohexol + Tromethamine) | IA;IV;IVP; IVPUSH;PO;R; RECT; | | | | | 1.體腔使用途徑以水稀釋，成人兒童及部位不同依1:1~1:50不等比例稀釋2.腎功能正常病患應立即停用Meformin 48小時，待腎功能恢復後再啟用;如腎功能不佳病患，請評估病患情況，提前48小時停用Meformin. |
| IOMN2 | Omnipaque 350mg I/mL，200mL (Iohexol + Tromethamine) | IA;IV;IVP; IVPUSH;R; RECT; | | | | | 1.體腔使用途徑以水稀釋，成人兒童及部位不同依1:1~1:50不等比例稀釋2.腎功能正常病患應立即停用Meformin 48小時，待腎功能恢復後再啟用;如腎功能不佳病患，請評估病患情況，提前48小時停用Meformin. |
| IOMN5 | Omnipaque 350mg I/mL，50mL (Iohexol + Tromethamine) | IA;IRR;IT;IV;IVP; IVPUSH;LI;PO; R;RECT; | | | | | 1.體腔使用途徑以水稀釋，成人兒童及部位不同依1:1~1:50不等比例稀釋2.腎功能正常病患應立即停用Meformin 48小時，待腎功能恢復後再啟用;如腎功能不佳病患，請評估病患情況，提前48小時停用Meformin. |
| IOPDI | Opdivo inj 120mg/12mL (Nivolumab) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。 【N/S】可選 仿單建議。 | | 抽取所需的OPDIVO容積，並注入靜脈輸液袋內。以0.9%氯化鈉注射液(USP)或5%葡萄糖注射液(USP)稀釋OPDIVO，製備成最終濃度為1 mg/mL至10 mg/mL的輸注液。對於體重 >=30 kg的病人給予240 mg、360 mg或480 mg固定劑量(flat-dose)的總體積不得超過150 mL而體重<30 kg的病人給予之總體積不得超過100 mL。輕輕翻轉混合稀釋液。請勿振搖輸液袋。部分使用或用完的OPDIVO藥瓶應予以丟棄。 | 1. 從製備開始至輸注結束，置於室溫和室內光照的時間不得超過8小時。如果在製備後的8小時內未使用，請丟棄稀釋液；或2. 從製備開始至輸注結束，冷藏於2°C-8°C的時間不得超過24小時。如果在製備後的24小時內未使用，請丟棄稀釋液。3. 請勿冷凍。4. 透過含無菌、無熱原、低蛋白結合率過濾器(孔徑大小為0.2微米至1.2微米)的靜脈導管連續輸注30分鐘。5. 請勿以相同的靜脈導管同時輸注其他藥物。6. 輸注結束後應沖洗靜脈導管。7. OPDIVO併用其他藥物的給藥方式如下：o 併用ipilimumab：OPDIVO先給藥，隨後於同一天給予pilimumab。o 併用化學治療時：OPDIVO先給藥，隨後於同一天給予化學治療。o 併用 ipilimumab和化學治療時，同一天應先給予OPDIVO接著給予 ipilimumab，最後再給予化學治療。o 併用fluoropyrimidine及含鉑化學治療：OPDIVO先給藥，隨後於同一天給予fluoropyrimidine及含鉑化學治療。8. 應使用個別的輸液袋和過濾器。 |
| IOREC | Orectalip inj 100mg/20mL (Oxaliplatin) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。 | | 以250-500mL D5W稀釋成濃度不低於0.2mg/mL的注射液，持續2~6小時點滴給藥。 | 1. 稀釋成濃度介於0.2mg/mL到0.7mg/mL之間的注射液。2. 必須由中央靜脈管或週邊靜脈持續2-6小時點滴給藥。3. 不可使用含鋁的注射器具。4. 不可和鹼性藥品或溶液併用。不可在同一個點滴瓶或輸注管內併用它藥。5. 稀釋後，在2℃到8℃的溫度下不應超過24小時。6. 當oxaliplatin和fluoropyrimidines併用時，應在給與fluoropyrimidine(例如5-fluorouracil)前先給與oxaliplatin。 |
| IOXA1 | Folep inj 100mg/20mL (Oxaliplatin) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。 | | Dilute oxaliplatin in 250-500mL of 5% dextrose solution to a concentration of 0.2-0.7 mg/mL. The diluted oxaliplatin infusion must be administered through a central venous line or peripheral vein as a 2-6 hour infusion. Oxaliplatin must be infused prior to 5-FU administration. | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 調配與注射的器具不可含有鋁。本藥品不可使用含有氯的稀釋溶液 (例如：N/S)，給藥時避免和鹼性藥物(例如：5-FU)使用相同管路。3. 稀釋後的輸注溶液在室溫下安定性維持24小時。在 2-8℃下可保存 48 小時。4. 監測CBC、腎功能，注意病人是否有呼吸方面的異常症狀。5. 定期神經學檢測。6. Oxaliplatin 一定要在 5-FU 之前先輸注。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOXY | Oxytocin inj 10 IU/1mL (Oxytocin) | IM;IVD;IVP; IVPUSH;SC; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【D5NS】可選 。【L/R】可選 。 | Slow IV injections (5 or 10 units over 1 minute) are preferred for women without cardiovascular risk factors; very slow injections (?5 minutes) are preferred for women with cardiovascular risk factors. | 注射速率:10~20 milliunit/min (postpartum bleeding) 輸注速率< 9~10 milliunit/min Maximum 40 units to 1000 mL IV solution. | |
| IOZU | Ozurdex (intravitreal implant) 0.7mg (Dexamethasone) | IVI; | | | | | 1.不建議雙眼同時接受注射 |
| IPAC | Pacxib inj 40mg (Parecoxib) | IM;IVD;IVPUSH; | 2mL N/S or D5W | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | may be administered rapidly and directly into vein or existing IV line. (Lexi-drug 20260406) | | 1. 調配好的Parecoxib注射液(不可冷藏或冷凍)。通常在25oC時儲存時間不可超過12小時。2.Parecoxib與鴉片類藥物(opioids)不可置於同一支針筒內給藥。3.林格氏乳酸鹽注射液(Ringer-Lactate solution)或含有葡萄糖50 mg/mL (5%)之林格氏乳酸鹽注射液會使parecoxib沉澱，因此不宜作為調配溶劑。4.注射用水也不宜用來調配Parecoxib，因為形成的溶液不是等張溶液。5.不可將Parecoxib注入正在輸注其他藥物的靜脈管線中。投與Parecoxib注射劑前後，必須用已知相容的溶液充分沖洗靜脈管線。6.不宜將Parecoxib注入正在輸注含有葡萄糖50 mg/mL (5%)之林格氏乳酸鹽注射液或其他未列於前述之靜脈輸液的靜脈管線中，因為可能會造成藥品沈澱。 |
| IPAM2 | Pampara inj 500mg/20mL (Pralidoxime) | IVD; | | 【N/S】可選 。 | slow injection | 以10~20 mg/mL 滴注 15~30 min，Max: 200 mg/min | Intravenous 1.dilute to a final concentration of 10 to 20 mg/mL in NS; infuse over 15 to 30 minutes 2.maximum infusion rate is 200 mg/min |
| IPAN4 | Pantoloc I.V. inj 40 mg (Pantoprazole) | IVD;IVPUSH; | 每一小瓶內注入 10mL 注射用生理食鹽水 sodium chloride 9mg/mL (0.9%) 溶解。 | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | administer over a period of at least 2 minutes | Reconstitute 1 vial (40 mg) with 10 mL of Normal Saline injection and then dilute to a total volume of 100 mL to a final concentration of approximately 0.4 mg/mL for a 40-mg dose. Administer IV over a period of 15 minutes at a rate of approximately 7 mL/min. | 配製後的溶液可直接注射投予或以100mL注射用生理食鹽水0.9% sodium chloride 9 mg/mL或5%葡萄糖注射液混合滴注。應使用玻璃或塑膠容器進行稀釋。配製後，或配製且稀釋後，使用期之化學與物理穩定性為25°C下可維持12小時。依據微生物觀點，應立即使用產品。除特定溶劑外, Pantoloc i.v. 不可與非指定溶劑進行配製或混和。使用靜脈注射投予，於2–15分鐘內注射完畢。 |
| IPARI | Paricalcitol inj 5mcg/1mL (Paricalcitol) | IVPUSH; | | | 通常於血液透析時經blood tubing注射。其他靜脈注射應緩慢，不少於 30 秒。 | | 1.給藥途徑通常是於血液透析時經血液通路(blood tubing)注射給予。對於未接受血液透析的病患應緩慢地給予靜脈注射，不少於30 秒，以降低注射疼痛。2.賦形劑:Ethanol absolute (dehydrated alcohol)、Macrogol 15 Hydroxystearate (Solutol HS 15R)、Water for injection |
| IPERD | Perdipine inj 10mg/10mL (Nicardipine) | IVD; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | 靜脈輸注時，稀釋成0.1-0.2 mg/mL濃度，成人起始劑量3-5 mg/hour，持續輸注15分鐘，但不可超過15 mg/hour;小兒起始劑量:0.5-5 mcg/kg/min，建議維持劑量為1-4mcg/kg/min。 | 依103年8月7日衛福部發佈於不良反應中心安全性評估結果。1.IV infusion 成人起始劑量:3-5 mg/h，持續輸注15分鐘，但不可超過15 mg/hour 2.IV infusion 老人、孕婦及肝腎功能不良者起始劑量1-5 mg/hour，不可超過15 mg/hour 3.IV infusion 小兒起始劑量:0.5-5 mcg/kg/min，建議維持劑量為1-4mcg/kg/min 4.本藥遇光會慢慢的變化。 |
| IPERJ | Perjeta inj 420mg/14mL (Pertuzumab) | IVD; | | | | Loading dose 840 mg as an intravenous infusion over 60 minutes，followed by 420 mg as an intravenous infusion over 30 to 60 minutes every 3 weeks. | 僅可使用0.9%氯化鈉注射液稀釋。不可使用葡萄糖(5%)溶液。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPET | Pethidine HCl inj 50mg/1mL (Meperidine) | IM;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【D5NS】可選 。【H/S】可選 。【L/R】可選 。 | 緩慢推注 | 以適當輸注液稀釋成1 mg/mL，給藥速率依病人反應進行調整不能連續超過48小時，或是累積劑量不能超過600mg/24小時 | 1. IM: 注射於大的肌肉。2. 給藥時最好讓病人躺下。3. 對於腎功能正常的病人，Pethidine 連續使用不能超過48 小時，或是累積劑量不能超過600 mg/24 小時。 |
| IPEY | Peyona inj 20mg/1mL (for infusion and oral) (Caffeine Citrate) | AC;AC15;IVD; PC;PO; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | X | Infuse loading dose 20 mg/kg as caffeine citrate may be infused over at least 30 minutes; maintenance dose 5 mg/kg/day as caffeine citrate once daily may be infused over at least 10 minutes. | 1.Caffeine citrate can be either used without dilution or diluted in sterile solutions for infusion such as glucose 50 mg/mL (5%) or sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) or calcium gluconate 100 mg/mL (10%) immediately after withdrawal from the ampoule. 2.Blood samples for monitoring should be taken just before the next dose in the case of therapeutic failure and 2 to 4 hours after the previous dose when suspecting toxicity. |
| IPG2 | PG2 inj 500mg (Polysaccharides of Astragalus membranaceus) | IVD; | 先抽10 mL N/S溶解乾粉，並注射回原500 mL點滴瓶 | 【N/S】可選 仿單建議。 | | 先抽10 mL N/S溶解乾粉，並注射回原500 mL點滴瓶 建議以2.5-3.5小時緩慢滴注，需使用0.22 micron fillter過濾 | 1.需使用需使用0.22 micron fillter過濾。2.先抽10 mL N/S溶解乾粉，並注射回原500 mL點滴瓶。3.每週2-4次使用，使用2-4週。4.若需預防輸注反應，可延長滴注時間。經詢問廠商(20220518)本藥泡製後之安定性可達24小時，但此安定性資料不包含配製時的微生物變因。 |
| IPHE | Phenobital inj 100mg/1mL (Phenobarbital) | IM;IVD; | | 【D10W】可選 。【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【H/S】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | Avoid IV push. | (Children) Inject IV at a rate not to exceed 30 mg/min. (Adult) Inject IV at a rate not to exceed 60 mg/min. | IM: Inject deeply into a large muscle. Avoid injection into or near peripheral nerves due to the risk of permanent neurological deficit. IV: Inject slowly to avoid severe respiratory depression，apnea，laryngospasm，hypertension or vasodilation with fall in blood pressure. |
| IPITR | Pitressin inj 20 Units/1mL (Vasopressin) | IM;IN;IVD;SC; | | 【D5W】可選 仿單建議。 | | 輸注速率 < 0.4 U/min | |
| IPLA25 | Plasbumin inj 25% 50mL (Albumin) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | 低蛋白血症患者若血容正常，輸注速率不宜超過2 mL/minute。 | 1. 本品小瓶被刺穿後超過4小時即不可投藥。2. 本品可以未稀釋或以0.9% NS或D5W稀釋後投予。禁以無菌水稀釋，以免導致嚴重溶血及急性腎衰竭。3. 本品可與全血、濃縮紅血球、以及供靜脈投藥用的標準碳水化合物和電解質液相容，但禁與蛋白質水解產物、胺基酸溶液或含酒精液混合。4. 本品鈉含量約為145 mEq/L，用於需要限制鈉攝取量的病人時應注意。5. 若溶液曾經冷凍，請勿使用。6. 只可使用16號注射針或調劑針，注射針或調劑針只可插入瓶塞上環狀凸起範圍內，瓶塞被穿刺的角度必須與瓶塞環狀凸起面垂直。 |
| IPRIM | Primovist inj 2.5 mmol/10mL (Gadoxetate) | IV; | | | 可馬上使用不需稀釋的靜脈注射水溶液，以大約2毫升/秒的流速施打。 | | 1. 一般成人使用劑量:0.1 mL/kg 2. 本藥品不應與其他藥品混合使用。3. 本預填針筒限單次使用，未用完的顯影劑一律丟棄。4. 本品為可馬上使用不需稀釋的靜脈注射水溶液，以大約2 mL/秒的速度施打。本品使用後，靜脈留滯針應用生理食鹽水沖洗。 |
| IPROA | Protamine sulphate inj 50mg/5mL (Protamine sulphate) | IVD; | | 【N/S】可選 。 | | IV infused over 10 minutes | 1. 經靜脈注射後，對肝素的中和作用在5-15分鐘內發生。2. 給藥過快可能引起低血壓（短暫或嚴重）或心搏過慢，增加過敏反應的風險。3. 1 mL含有硫酸魚精蛋白1400 抗肝素國際單位 anti-heparin IU (10mg )。4. 最大單一注射劑量不應超過50mg/5mL。 |
| IPROM | Promostan inj 20mcg (Alprostadil) | IVD;LI; | IV:5 mL N/S | 【N/S】可選 仿單建議。 | | IVD: 5-10ng/kg/min | 1.Max:20 mcg/mL 2.給藥速率體重每公斤2小時內不超過1.2mcg. |
| IPROP | Propofol-Lipuro 1% 20mL (Propofol) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | 全麻用法 IVD: 50~100mcg/kg/min，輸注時間不宜超過12小時，使用濃度勿低於2mg/mL。(最大稀釋比例 1:4) | 1.使用濃度勿低於2 mg/mL。(最大稀釋比例 1:4) 2.輸注時不可使用含微生物過濾器之輸液套。輸注本品建議使用流速滴定或體積設定幫浦控制流速。3.本品不含防腐劑，開瓶後應立即抽取至無菌針筒或輸液套，剩餘的殘量應丟棄不用。4.輸注未經稀釋的Propofol 1% 20mL時，使用同一系統輸注時間不宜超過12小時。使用12小時後，輸注管路與剩餘的藥物應丟棄、更換。5.輸注稀釋過的Propofol 1% 20mL時，應於投藥前以無菌操作立即調配，且務必於8小時內使用。6.可以藉由選擇前臂及肘前窩處較大靜脈血管進行注射來減低疼痛。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPUL | Pulin inj 10mg/2mL (Metoclopramide Hydrochloride) | IM;IVD;IVPUSH; | | 【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | over 1 to 2 minutes | The following Administration of Recommended is according to UpToDate(20221206): Adult，higher doses (>10 mg) are to be diluted in 50 mL of compatible solution (preferably N/S) and at least 15 minutes. | 1. The following Administration of Recommended is according to UpToDate (20221206): lower doses (< or =10 mg) of metoclopramide can be given IV push undiluted over 1 to 2 minutes. 2. 遲發性運動障礙(Tarddive dyskinesia)發生的風險與總累積劑量有正相關性，分析後有20%病患使用超過12週，故不建議長期(>12週)使用，除非經過評估其治療效益高於Tarddive dyskinesia之風險。3. 出現錐體外副作用症狀時請停止給藥，尤其是小兒族群比成人更容易發生。 |
| IRAPI | Rapiacta 300mg/60mL Drip Infusion (Peramivir) | IVD; | | | X | Administer via IV infusion over 15 to 30 minutes | 1. 急性流感宜於症狀發生後48小時內使用本藥。2. 對18歲以上成人急性流感病患之建議劑量為單次投與300 mg，15分鐘以上單次點滴靜脈注射。3. 每袋藥品賦形劑為氯化鈉540.0 mg及注射用水。(有心臟、循環器官功能不良者、腎功能不全者需注意) 4. 穿刺針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉、重複穿刺或用力過猛，以免產生碎片。 |
| IRECB | Recormon inj 2000IU (限洗腎室用) (Epoetin beta) | IVD;IVPUSH;SC; | | | 注射藥劑的時間要大於兩分鐘，血液透析病人可以在洗腎結束時經由動-靜脈婁管進行注射。 | 靜脈注射時，注射藥劑的時間要大於兩分鐘，血液透析病人可以在洗腎結束時經由動-靜脈婁管進行注射。 | 1.在沒有相容性研究的情況下，本品不可與其它藥物混合使用。2.配製好溶液可以經由皮下或是靜脈注射使用。當使用靜脈注射時，注射藥劑的時間要大於兩分鐘，譬如說，血液透析病人可以在洗腎結束時經由動靜脈婁管進行注射。 |
| IREL | Relaxin inj 500mg (Succinylcholine) | IM;IVD;IVPUSH; | N/S or D5W，250mL or 500mL. Final concentration of 1 or 2 mg/mL. (0.1% or 0.2% solution) | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | for Intubation: Adult dose - 0.6 mg/kg (range: 0.3 to 1.1 mg/kg) | IVD: (continuous infusion) a solution diluted to 1 mg/mL in D5W or N/S may be administered at a rate of 0.5 to 10 mg/min depending on patient specific factors. | Do not mix with alkaline solutions having a pH greater than 8.5 (eg, barbiturate solutions). Add 1 g succinylcholine to 1000 or 500 mL sterile solution (eg，D5W or NS) for a final concentration of 1 or 2 mg/mL. (0.1% or 0.2% solution) |
| IREMI | Remifentanil inj 2mg (Remifentanil) | IVD;IVPUSH; | 2mL DW，D5NS，D5W，HS，NS | 【D5NS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【H/S】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | 不得少於30秒。 | 稀釋成濃度20至250 mcg/mL，持續輸注的起始速率為0.5 mcg/kg/min。 | 1. 稀釋後的稀釋溶液24小時內馬上使用，未用完者必須丟棄。2.不相容性:(1)不可與Lactated Ringer's 注射液混和。(2)不可與Lactated Ringer's/5% Dextrose注射液混和。(3)不可與propofol之同一靜脈輸注藥品混和溶液中使用。(4)不建議注入與血液/血清/血漿同一靜脈輸注管路中。因為血液製品內不具專一性之esterase可能將remifentanil水解成不具活性之代謝物。(5)輸注前不可與其他治療藥物混和。 |
| IRIN4 | Rinderon inj 4mg/1mL (Betamethasone) | IM;INS;IS;IVD;IVP;IVPUSH;LI;SPI; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | Slow intravenous injection over half to one minute. | 1-5mL (4-20mg) daily diluted in Normal Saline or Dextrose Water. | 1.未稀釋亦可使用2.1-3 mL IV or IM slowly 3-4 hourly |
| IROCU | Rocuronium Kabi 50mg/5mL(僅備於麻醉科) (Rocuronium Bromide) | IVD;IVPUSH; | | 【D5NS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | IV bolus as an adjunct to facilitate tracheal intubation. | 0.3~0.4mg/kg/h (濃度:0.5 mg/mL 或 2 mg/mL ) | 1.Rocuronium bromide 以靜脈投藥採一次注入或連續輸注方式 |
| ISAN1 | Sandostatin inj 0.1 mg/1mL (Octreotide) | IVD;SC; | | 【N/S】可選 仿單建議。 | | Bleeding gastro-oesophageal varices 50 mcg/hr by IV infusion for max 5 days. | |
| ISEF | Seforce inj 400mg/200mL (Ciprofloxacin) | IVD; | | 【D10W】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | Ciprofloxacin輸注液必須經由靜脈輸注，並且輸注時間要超過60分鐘。緩慢的將藥打入大的靜脈，可以減少病人的不適及降低靜脈刺激的危險性。可以直接給藥或與其它相容的輸注溶液混合後給藥。 | 1.本藥具光敏感度，藥品須在使用前再從避光袋拿出。在白晝光線下，完整的效力只能保證維持3天。2.低溫儲存環境可能會產生沉澱，但在室溫下會再度溶解。所以不須將此輸注液置於冰箱儲存。3.使用IV set 時請確實辨認加藥孔及輸出孔，將IV set 垂直插入至輸出孔，並確認完全插入至底部。4.依2016年第2次ADR會議決議: 因Quinolones類藥物常見引起靜脈炎，建議輸注時間應超過60分鐘。 |
| ISEV | Sevatrim inj 400/80mg (Sulfamethoxazole + Trimethoprim) | IVD; | | 【D10W】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | 建議輸注時間約為1.5小時 | |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIMD | Simdax inj 12.5mg/5mL (Levosimendan) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。 | X | Dilute to 0.025 - 0.05 mg/mL before administration. Initial bolus dose: 6-12 mcg/kg over 10 minutes. Continuous infusion dose: 0.05-0.2 mcg/kg/min. | Lower loading dose of 6 mcg/kg is recommended in patients on concomitant IV vasodilators or inotropes or both at start of infusion. Rate of infusion may be decreased to 0.05 mcg/kg/min or discontinued if response is deemed excessive; may be increased to 0.2 mcg/kg/min if initial dose is tolerated. Duration of infusion: 24 hr. 稀釋後的藥品，其化學及物理安定性於25°C下可維持24小時。對於急性失代償性嚴重慢性心衰竭病人的建議輸注時間為24小時。 |
| ISLIP | SMOFlipid 20% inj 250mL (MCT + Fish oil + Olive oil + Soybean oil) | IVD; | | | | Adults infusion rate: 0.125-0.15 gm of fat/kg/hour (0.63-0.75 mL/kg/hour) Newborns/infants infusion rate: <= 0.125 gm of fat/kg/hour (0.63 mL/kg/hour) Children infusion rate: <= 0.15 gm of fat/kg/hour (0.75 mL/kg/hour) | 1. 可由周邊或中心靜脈輸注給藥。2. 當用於新生兒和2 歲以下兒童時，溶液和輸液袋應避光直至給藥完成。3. 使用前須確認乳劑沒有層相分離或沉澱物，呈均質狀態才可使用。4. 發生副作用或輸注期間三酸甘油酯濃度上升超過3 mmol/L，應停止輸注或視需要降低劑量繼續輸注。 |
| ISLIP1 | SMOFlipid (小兒TPN用 100mL 20%) (MCT + Fish oil + Olive oil + Soybean oil) | IVD; | | | | Adults infusion rate: 0.125-0.15 gm of fat/kg/hour (0.63-0.75 mL/kg/hour) Newborns/infants infusion rate: <= 0.125 gm of fat/kg/hour (0.63 mL/kg/hour) Children infusion rate: <= 0.15 gm of fat/kg/hour (0.75 mL/kg/hour) | 1. 可由周邊或中心靜脈輸注給藥。2. 當用於新生兒和2 歲以下兒童時，溶液和輸液袋應避光直至給藥完成。3. 使用前須確認乳劑沒有層相分離或沉澱物，呈均質狀態才可使用。4. 發生副作用或輸注期間三酸甘油酯濃度上升超過3 mmol/L，應停止輸注或視需要降低劑量繼續輸注。 |
| ISOBI | NaHCO3 (Rolikan) 7% inj 20mL (Sodium Bicarbonate) | IH;IRR;IVD;IVP; IVPUSH;LI;SC; | | 【D5W】可選 仿單建議。【D10W】可選 。【D5NS】可選 。【N/S】可選 。 | Administer slowly (maximum rate in infants: 10 mEq/minute) | IV infusion，dilute to a maximum concentration of 0.5 mEq/mL in dextrose solution and infuse over 2 hours (maximum rate of administration: 1 mEq/kg/hour) 未稀釋亦可使用，不可與含鈣製劑混合使用 | 1. 16.7 mEq / 20 mL / Amp 2. For I.V. administration to infants，use the 0.5 mEq/mL solution or dilute the 1 mEq/mL solution 1:1 with sterile water 3. Direct I.V. infusion in emergencies: administer slowly (maximum rate in infants: 10 mEq/minute) 4. IV infusion，dilute to a maximum concentration of 0.5 mEq/mL in dextrose solution and infuse over 2 hours (maximum rate of administration: 1 mEq/kg/hour) 5. Avoid extravasation，tissue necrosis can occur due to the hypertonicity of NaHCO3 6. 藥品拆開塑膠包裝後，請於開封26天內使用。(20260330廠商來信) |
| ISONA | Sonazoid inj 8 microliter/mL，2mL (Perfluorobutane microbubbles) | IVP;IVPUSH; | 藥品專用稀釋液 | | IV bolus for contrast-enhanced ultrasonography. | | 1.使用注射針孔徑至少為22G。2.靜置時懸浮液會分離，所以在投與之前，請立即搖晃本品，以確保內容物的均一性。3.在投藥後應立即以少量的等張氯化鈉溶液(ISCS) 沖洗注射途徑。4.僅供單次使用。5.懸液應在配製後之2小時內使用 |
| ISONV | SonoVue inj 60.7mg (Sulphur hexafluoride microbubbles) | IVD;IVPUSH; | 隨貨附給的生理食鹽水注射液5mL | 【N/S】可選 仿單建議。 | | | 1. 使用廠商隨貨附給的生理食鹽水注射液與柏朗注射器，依照仿單進行配製。配製完成後室溫保存，須於3小時內使用。若配製完沒有立即使用，應搖晃藥物數秒使微泡重新懸浮。2. 本藥不可動脈內給藥 3. 給藥後請密切觀察病患反應至少30分鐘，大多數嚴重的不良反應在用藥後30分鐘內發生。 |
| ISOO | Soonmelt inj 600mg (500mg/100mg) (Amoxicillin + Clavulanic Acid) | IVD;IVP; IVPUSH; | 10 mL D/W (稀釋液需在20分鐘內使用) | 【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | 推注時間至少3 ~ 4分鐘 | 以30 ~ 40分鐘緩慢滴注 | 1. 注射前檢查病患是否有 penicillin 過敏史。2. 稀釋後應儘快使用，安定性與稀釋濃度與保存條件有關。3. 每小瓶的Soonmelt inj. 600mg中，含有0.5 mmol 的鉀與 1.55 mmol 的鈉 (估計值)。4. 本產品不適用於肌肉注射給藥。5.不可以血液製劑、其他蛋白液或靜脈注射用脂肪乳劑混合使用。5. IV bolus: Amoxycillin 500mg + Clavulanic acid 100mg/vial 乾粉加入10 mL D/W泡製。6. IV infusion: 每小瓶以50 mL適當輸注液稀釋，以30 ~ 40分鐘緩慢滴注。本藥品不可加入含有葡萄糖、聚葡萄糖或重碳酸鹽的輸注溶液。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTI3 | Stilamin inj 3mg (Somatostatin) | IVD;IVPUSH; | N/S 1 mL 溶解乾粉 (202604 Lexi-drug) | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | 250 mcg IV bolus 以3~5分鐘之慢速度注入。 | 每小時250 mcg持續輸注。(3.5 mcg/kg/hour) | 1. 以生理食鹽水溶解後注射液安定性可達24小時。2. 凍結乾燥的粉末應在使用前才用生理食鹽注射液溶解。3.要連續點滴時，應用一安瓿3 mg的Stilamin調配12小時用之點滴液。點滴液可用生理食鹽水或5 %葡萄糖調配，而且必須調整點滴的速度確實為每小時250 μg之Somatostatin。 |
| ISTO | Stogamet inj 200mg/2mL (Cimetidine) | IM;IVD;IVPUSH; | | 【D10W】可選 仿單建議。<br>【D5W】可選 仿單建議。<br>【L/R】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | 以適合的溶液把300mg本品稀釋成20mL溶液，以長於2分鐘的速率緩慢的靜脈注射，這種給藥方式應避免使用在患有心臟血管疾病的患者。 | 本品300mg稀釋在100mL適合的靜脈注射溶液中，靜脈點滴15-20分鐘以上，點滴的平均速率在24小時期間不超過75mg/小時。 | Cimetidine 注射液以0.9%氯化鈉注射液，5%或10%右旋醣注射液，乳酸化林格氏液稀釋後於室溫下可保存1個星期。 |
| ISUP | Supren inj 8mg/4mL (Ondansetron) | IM;IVD;IVPUSH; | | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | For each 4-mL dose, administer slowly over 30 seconds or longer (2-5 minutes). | Adult: for dose over 8 to a maximum of 16 mg, dilute in 50-100 mL of compatible infusion fluid and give by intravenous infusion over no less than 15 minutes. A single dose should not exceed 16 mg. | 1. 本品不可與其他藥物使用同一注射針筒或點滴輸注液同時給藥。2. 本品可經由輸注袋或注射筒幫浦以1mg/hour的速率靜脈輸注給藥。3. 靜脈輸注液應於輸注前才調配，本品和合適的靜脈輸注液混合後，置於室溫(25℃以下)的螢光燈下或冷藏可維持安定達7天。 |
| ITAI | Taigexyn inj 500mg/250mL (Nemonoxacin) | IVD; | | | | 靜脈緩慢滴注，滴注時間不少於90 分鐘。 | |
| ITAP | Tapimycin inj 2.25gm (2gm/0.25gm) (Piperacillin + Tazobactam) | IVD; | 10 mL D/W | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | 以 > 30分鐘速率緩慢滴注。(給本藥輸液時，需暫停原有之輸液給藥。) | 1. 注射前檢查病患是否有PCN過敏史。2. 監測體溫、CBC、血球分化計數、血鉀、肝腎功能。 |
| ITAR | Targocid inj 200mg (Teicoplanin) | IM;IMP;IRR;IVD;<br>IVP;IVPUSH; | IM，IV: 3mL D/W | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【L/R】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | 推注時間至少3 ~ 5分鐘 | 建議以30分鐘緩慢滴注 | 1. 勿用力搖晃，若出現泡沫可靜置15分鐘。2. 稀釋後應於24小時內使用。監測體溫、CBC，長期使用需注意聽力變化。3.本品與aminoglycoside類抗生素不相容，不可混合或同時注射。4.對Vancomycine過敏者應小心使用，可能發生交叉過敏。 |
| ITAX8 | TAXOTERE inj 80mg/4mL (Docetaxel) | IVD; | | | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 稀釋溶液與器具應使用玻璃、聚丙烯(polypropylene)、聚烯(polyolefin)材質，不可使用含PVC塑膠材質。給藥時應使用polyethylene 材質的輸液套。3. 配製好的輸注溶液濃度避免超過 0.74 mg/mL，配置好6小時內以靜脈輸注方式使用(包含輸注時間)，在低於25℃以下給予病患。使用前應再次目視檢查，若有沉澱物或結晶應予以丟棄。4. 注射前應先給予預防過敏的藥物。5. 監測CBC、肝功能。 |
| ITAXO | Taxotere inj 20mg/1mL (Docetaxel) | IVD; | | | | | 1. 本品為化療藥物，輸注時需注意注射部位，防止藥液外滲。2. 稀釋溶液與器具應使用玻璃、聚丙烯(polypropylene)、聚烯(polyolefin)材質，不可使用含PVC塑膠材質。給藥時應使用polyethylene 材質的輸液套。3. 配製好的輸注溶液濃度避免超過 0.74 mg/mL，配置好6小時內以靜脈輸注方式使用(包含輸注時間)，在低於25℃以下給予病患。使用前應再次目視檢查，若有沉澱物或結晶應予以丟棄。4. 注射前應先給予預防過敏的藥物。5. 監測CBC、肝功能。 |
| ITEC | Tecentriq inj 1200mg/20mL (Atezolizumab) | IVD; | | 【N/S】可選 仿單建議。 | | 給藥：第一次以60分鐘透過裝或不裝有無菌、非致熱原性(non-pyrogenic)、低蛋白結合性的管線內置型過濾器(孔徑尺寸為0.2至0.22微米)靜脈給予。若病人可耐受可以30分鐘進行輸注。請勿經由相同的靜脈管線同時給予其他藥物。不得以靜脈推注(push)或快速灌注(bolus)方式給予 | 1.製備輸注溶液：注入含有0.9%美國藥典規格之氯化鈉注射液的250 mL聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)或聚烯烴(PO)輸注袋中稀釋。僅可使用0.9%氯化鈉注射液稀釋。輕輕反轉以混合稀釋溶液。不可搖晃。2.儲存溶液：於室溫下，從製備時起算不超過6小時。這包括室溫下輸注液裝於輸注袋中，以及輸注給藥的時間，或從製備時起算，冷藏於2°C至8°C下不超過24小時。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRA5 | Tractocile inj 5mL (7.5 mg/mL) infusion (Atosiban) | IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | 初始劑量:6.75mg/0.9mL 推注1分鐘 | 維持劑量:100~300 mcg/min | 1.不可與其他藥物混合2.維持劑量:100~300 mcg/min 3.起始劑量:7.5mg/mL，推注時間至少1分鐘 |
| ITRAD | Trandate 針劑 25mg/5mL (Labetalol hydrochloride) | IVD;IVPUSH; | | 【L/R】可選 。【N/S】可選 。【D5NS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【D2.5HS】可選 。 | Administer IV over 1 minutes | Micromedex Adult Dosing : Add 40 mL of labetalol (200 mg) to 250 mL of a compatible IV fluid for a final concentration of approximately 2 mg/3 mL. Pediatric Dosing: 1.General Dosage Information:Safety and efficacy not established in pediatric patients. 2. Hypertension: (1 year or older) (1 year or older) Infusion: 0.25 to 3 mg/kg/hour IV infusion (guideline dosage). | 1. Do not dilute in 5% sodium bicarbonate. 2. Patient should remain supine during and for up to 3 hours following injection. |
| ITRAM | Tramtor inj 100mg/2mL (Tramadol) | IM;IVD;IVP; IVPUSH;SC; | | 【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | 推注時間至少2 ~ 3分鐘 | infusion concentration 0.5-4 mg/mL. | |
| ITRAN | Transamin inj 250mg/5mL (Tranexamic Acid) | IM;INS;IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | 1000 mg 推注時間至少 10 mins (速率 < 2 mL/min) | 1000 mg 推注時間至少 10 mins 輸注速率 < 2500mg/24hr | 1. 靜脈內注射時應緩慢進行，急速給藥時，可能會出現噁心、胸部不適、心悸亢進或血壓下降。2.不可與血品或含penicillin的藥物混合 |
| ITRI1 | Triamcinolone 10mg/1mL (Triamcinolone) | ID;IM;INS;IVI;LI; SKIN; | | | | | |
| ITRI4 | 4% TRIAMCINOLONE 40mg/1mL (Triamcinolone) | ID;IM;INS;IVI; SKIN;SUBCI; | | | | | |
| ITRO | Trodelvy inj 180mg (Sacituzumab govitecan) | IVD; | 20mL 0.9% NaCl (Final concentration: 10 mg/mL) | 【N/S】可選 仿單建議。 | | Dilute with 0.9% NaCl solution to a final concentration of 1.1 to 3.4 mg/mL. Infuse over 3 hours for the initial dose. Subsequent infusions may be infused over 1 to 2 hours or longer if tolerated. | 1. 僅供靜脈滴注(IVD)給藥，可使用輸注幫浦。輸液袋應避光直到給藥完成，輸液過程中無需遮蓋輸液管線或使用避光管線。可使用輸注幫浦。2. 稀釋後溶液濃度範圍為1.1 mg/mL至3.4 mg/mL (對於體重<=170kg 病人，總溶液量不應超過500mL) 3. 含本品溶液的輸液袋於2-8°C冷藏並避光保存最長至24小時。冷藏保存後，稀釋溶液於最高至25°C的室溫下應在8小時內(含輸注所需的時間)投予。4. 首次輸注：輸注進行時間超過8小時。後續輸注：如果對先前的輸注具有耐受性，則輸注時間可在1至2小時以上。在輸注期間和輸注後至少80分鐘觀察病人是否出現輸注相關反應的徵兆或症狀。 |
| ITYG | Tygacil inj 50mg (Tigecycline) | IVD; | 1.IVD: 5.3 mL N/S或D5W或L/R，調配成藥液濃度10mg/mL，只需取出5mL. | 【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | | 給藥濃度≦ 1mg/mL，建議以 >30 ~ 60分鐘緩慢滴注 | 1. 稀釋於小瓶內的溶液室溫最多擺放6小時，稀釋好的輸注溶液室溫下最多擺放24小時 (包含原先在小瓶內的6小時)。因此，若使用方式為25mg Q12H，建議將小瓶內剩餘的藥液置於冰箱冷藏(最多48小時)，下次給藥前再加於輸注溶液。2. 藥液若變色則不可使用。(調配好的藥液應呈黃色或橙色) 3. Tygacil給藥時必須使用專用的輸注管路，或使用Y型輸注管路，以便與其他輸注藥液區別。4. 監測體溫、CBC與感染症狀變化。5. 監測肝功能。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITYN2 | Tynen inj 20mg/1mL (Docetaxel) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | 注入250mL稀釋液中，每次輸注時間1小時。(避免濃度超過0.74 mg/mL) | 1. 處理及配製docetaxel溶液應小心，建議使用手套。2. 液接觸到皮膚或黏膜時，應立刻徹底以肥皂及清水清洗。3. 使用前應先將所需使用之數量的輸注用濃縮液取出並靜置於25°C以下，5分鐘之後再行使用。4. 應使用21號針頭，置備時須以有刻度之注射針筒在無菌操作情形下抽取適量小瓶之Tynen(docetaxel)輸注濃縮溶液。5. 輸注液須在配製好6 小時內以靜脈輸注方式使用(包含輸注時間1 小時)，在低於 25°C 及一般亮度之環境下給予病人。在非PVC 輸注袋(聚烯烴袋 polyolefin bag)配製之輸注液，其化學及物理安定性為在2℃到 8℃下可保存 48 小時。6. 於治療乳癌及非小細胞肺癌時如，於每個治療週期開始前一天起，連續3天，每日服用 dexamethasone 16 mg（例如一天兩次，每次8 mg），以減少體液滯留的發生率及嚴重程度，和降低過敏反應的嚴重程度。7. 前列腺癌的治療前給藥，應於開始輸注前12 小時、3 小時及 1 小時口服投予 dexamethasone 8 mg。 |
| ITYN8 | TYNEN inj 80mg/4mL (Docetaxel) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | 注入250mL稀釋液中，每次輸注時間1小時。(避免濃度超過0.74 mg/mL) | 1. 處理及配製docetaxel溶液應小心，建議使用手套。2. 液接觸到皮膚或黏膜時，應立刻徹底以肥皂及清水清洗。3. 使用前應先將所需使用之數量的輸注用濃縮液取出並靜置於25°C以下，5分鐘之後再行使用。4. 應使用21號針頭，置備時須以有刻度之注射針筒在無菌操作情形下抽取適量小瓶之Tynen(docetaxel)輸注濃縮溶液。5. 輸注液須在配製好6 小時內以靜脈輸注方式使用(包含輸注時間1 小時)，在低於 25°C 及一般亮度之環境下給予病人。在非PVC 輸注袋(聚烯烴袋 polyolefin bag)配製之輸注液，其化學及物理安定性為在2℃到 8℃下可保存 48 小時。6. 於治療乳癌及非小細胞肺癌時如，於每個治療週期開始前一天起，連續3天，每日服用 dexamethasone 16 mg（例如一天兩次，每次8 mg），以減少體液滯留的發生率及嚴重程度，和降低過敏反應的嚴重程度。7. 前列腺癌的治療前給藥，應於開始輸注前12 小時、3 小時及 1 小時口服投予 dexamethasone 8 mg。 |
| IURO | UROKINASE 60, 000IU (綠十字) (Urokinase) | IA;IPL;IRR;IVD; | | | | 1. Total dose diluted to the recommended final volume of 195 mL 2. (loading dose) 90 mL/hr over 10 minutes (continuous infusion) 15 mL/hr for a period of 12 hr | 1. Total dose diluted to the recommended final volume of 195 mL 2. (loading dose) 90 mL/hr over 10 minutes (continuous infusion) 15 mL/hr for a period of 12 hr |
| IVAB | Vabysmo intravitreal inj 6mg/0.05mL (Faricimab) | IVI; | | | | | 1. 僅供玻璃體內注射使用。Vabysmo 必須由具備玻璃體內注射經驗的合格醫師給予。每小瓶僅應使用於治療單眼。2. 注射當天眼內壓>=30mmHg，宜先控制。3. 未開封的小瓶可置於室溫下(20-25oC)最長24小時。 |
| IVAN5 | Vancomycin inj 500mg "CYH" (Vancomycin) | IMP;INS;IRR;IS;IVD;IVI;SCI;SUBCI; | 10mL D/W | 【D5NS】可選 仿單建議。<br>【D5W】可選 仿單建議。<br>【L/R】可選 仿單建議。<br>【N/S】可選 仿單建議。 | | 加入至少100 mL的稀釋液稀釋，靜脈注射超過60分鐘。 | 1. 配好之液可貯存於冰箱中96小時。2. 血栓性靜脈炎可能發生，但若以稀釋溶液（2.5~5 g/L）徐緩注射並輪流改變灌注部位，則此反應發生的頻率和嚴重性能減至最少。 |
| IVC5 | Vitamin C (Vitacicol) inj 100mg/2mL (Ascorbic Acid) | IM;IVD;SC; | | 【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | 以最少等量體積的輸注液稀釋後，緩慢輸注超過10分鐘 | 1. 本藥劑會影響各種尿糖檢查值，可能造成假陰性反應。2. IV注射太快可能引起暈眩不良反應。靜脈注射時，建議以最少等量體積的輸注液稀釋後，緩慢輸注超過10分鐘。3. 稀釋後的注射溶液建議避光存放並盡快使用完畢。4. 本藥劑含Benzyl Alcohol，Benzyl Alcohol劑量>99mg/kg/day不適宜用於新生兒。(賦形劑濃度:10mg/mL) |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVEK | Veklury inj 100mg (公費/凍晶) (Remdesivir) | IVD; | 19mL注射用水 | 【N/S】可選 仿單建議。 | | 對成人與體重大於40公斤的兒童，第1天的投藥(Remdesivir 200mg)應使用2支小瓶，並應將每支小瓶中的20mL溶液(共40mL)加入生理食鹽水中，使總體積達到100mL或250mL。以30-120分鐘的時間靜脈輸注。至於第2天起的投藥(Remdesivir 100mg)，則應將1支小瓶中的20mL溶液加入生理食鹽水中，使總體積達到100mL或250mL。以30-120分鐘的時間靜脈輸注。 | 1.將19mL注射用水加入小瓶中，立即再度振搖30秒。靜置2-3分鐘之後，應確認小瓶中的溶液是否澄清(濃度:5mg/mL)。如果小瓶中的內容物未完全溶解，應重複振搖小瓶，使內容物澄清。2.輸注完成之後，請用至少30毫升的0.9%生理食鹽水沖洗。3.以注射用水調製之後，稀釋的emdesivir溶液在20-25℃的溫度下應於4小時內進行製備，在2-8°C的溫度下應於24小時內進行製備。4.製備好的稀釋溶液在室溫(20-25°C)下可維持安定4小時，在2-8°C的冰箱中可維持24小時。 |
| IVEKS | Veklury (政府自費) inj 100mg (凍晶) (Remdesivir) | IVD; | 19mL注射用水 | 【N/S】可選 仿單建議。 | | 對成人與體重大於40公斤的兒童，第1天的投藥(Remdesivir 200mg)應使用2支小瓶，並應將每支小瓶中的20mL溶液(共40mL)加入生理食鹽水中，使總體積達到100mL或250mL。以30-120分鐘的時間靜脈輸注。至於第2天起的投藥(Remdesivir 100mg)，則應將1支小瓶中的20mL溶液加入生理食鹽水中，使總體積達到100mL或250mL。以30-120分鐘的時間靜脈輸注。 | 1.將19mL注射用水加入小瓶中，立即再度振搖30秒。靜置2-3分鐘之後，應確認小瓶中的溶液是否澄清(濃度:5mg/mL)。如果小瓶中的內容物未完全溶解，應重複振搖小瓶，使內容物澄清。2.輸注完成之後，請用至少30毫升的0.9%生理食鹽水沖洗。3.以注射用水調製之後，稀釋的emdesivir溶液在20-25℃的溫度下應於4小時內進行製備，在2-8°C的溫度下應於24小時內進行製備。4.製備好的稀釋溶液在室溫(20-25°C)下可維持安定4小時，在2-8°C的冰箱中可維持24小時。 |
| IVER | U-sodin inj 5mg/2mL (Verapamil) (Verapamil) | IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 。【D5NS】可選 。【N/S】可選 。 | 推注時間至少5分鐘 | | 1.不可與含sodium lactate藥物混合. 2.不可與pH值大於6的藥物混合，會有沉澱發生。(Micromedex) |
| IVFEN | Vfend inj 200mg (Voriconazole) | IVD; | IVD: 19 mL注射用水，配製成20 mL的透明溶液 | 【D5NS】可選 。【D5W】可選 。【N/S】可選 。 | | 給藥濃度0.5~5mg/mL，給藥速率最高 3mg/kg/hr | |
| IVIM | Vimpat 針劑 200mg/20mL (Lacosamide) | IVD;IVP; IVPUSH; | | 【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | may infuse over 15 minutes | Lacosamide injection may be administered without further dilution or mixed with NS, D5W, or LR. Preferably infuse over a period of 30 to 60 minutes; may infuse over 15 minutes if needed. | Preparation: If diluted prior to infusion, store at room temperature and administer within 4 hours of dilution. |
| IVIR | Virless inj 250mg (Acyclovir) | IVD; | IVD: 10mL D/W, N/S | 【H/S】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | > 60分鐘以上時間緩慢滴注。加入適當輸注液稀釋，濃度不可超過 5 mg/mL。 | 1.本品不含抗菌劑，配製或稀釋後的溶液應立即使用，不可冷藏。2.本品應以緩慢靜脈輸注1小時給藥而非 IV bolus，並給予充足水分補充，避免血尿素與肌胺酸酐快速增加。3.稀釋方法:每小瓶250 mg 乾粉加入 10 mL 注射用水或0.9%注射用生理食鹽水溶解。取出醫囑所需劑量，加入適當輸注液稀釋，最終濃度不可超過5 mg/mL。4.依照指示配製後的靜脈輸注液pH值約為 11，不可冷藏，應儲存於25℃以下。室溫下(15-25℃)可保持12小時的穩定性。5.如在輸注前或輸注中發現溶液中出現混濁或結晶時，應立即丟棄。6.較高濃度(如 10 mg/mL)容易產生靜脈炎、注射部位發炎。如果發生外滲，則採用乾熱和抬高治療，避免中和pH 值，沿著外滲部位和水腫組織注射hyaluronidase，動脈內外滲應考慮給予全身肝素和星狀神經節阻斷術治療。7.監測病人體溫、CBC、腎功能、感染症症狀。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVIS | Visudyne inj 15mg/vial (Verteporfin) | IVD; | | 【D5W】可選 。 | | 建議以10分鐘緩慢滴注. 建議使用孔徑不小於1.2μm過濾器的輸注管線. | 1.不可用生理食鹽水，會沉澱。2.以7mL"無菌注射用水"加入小瓶中，此時濃度為2mg/mL的7.5mL溶液，溶液呈不透明暗綠色溶液。3.本品溶解稀釋後須立即使用，限單次使用。(25℃下，4個小時內化學物理安定) 4.抽出所需劑量，再以D5W稀釋成30mL輸注液，輸注10分鐘。5.建議使用臨床試驗使用的含孔徑不小於1.2 μm過濾器的輸注管線。6.注射時應預防滲漏。若發生滲漏，應立即停止輸注，保護該部位避免強光直射直到腫脹及皮膚變色的情形消失，冷敷可減輕症狀。7.若藥品配製時潑灑出，須以濕布擦拭。避免與眼睛及皮膚接觸。 |
| IVISI | Visipaque inj 320mg I/mL，100mL (Iodixanol) | IA;IT;ITH;IV;IVP; IVPUSH; | | | | | |
| IVIT | VitaCAL inj 5.44 mEq/20mL (5.44 mg/mL) (Calcium Chloride + Dextrose) | IVD; | | | | | 1. 1 g calcium chloride = elemental calcium 273 mg = calcium 13.6 mEq = calcium 6.8 mmol 2. For IV administration only and administration via central or deep vein is preferred. 3. stop the infusion if the patient complains of pain or discomfort. 4. Monitor ECG if calcium is infused faster than 2.5 mEq/minute 5. Do not infuse calcium chloride in the same IV line as phosphate-containing solutions. 6. Avoid rapid administration (do not exceed 100mg/minute). 每毫升鈣含量:鈣原子量:40.078 (5.44/2)/2*40.078=5.45mg/ml |
| IWINB | Winbest inj 10mg/5mL (Cisatracurium) | IVD;IVPUSH; | | 【D2.5HS】可選 仿單建議。【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | Dilute cisatracurium injection to 0.1-2.0 mg/mL in PVC or polypropylene containers. | 1. 僅供靜脈給藥。2. 使用氯化鈉0.9%、葡萄糖5%、氯化鈉0.45%和葡萄糖2.5%靜脈注射溶液稀釋cisatracurium注射劑至0.1-2.0 mg/mL，用PVC或聚丙烯polypropylene 容器。在5℃和25℃下，安定性可維持24小時。3. 本品與以下藥物不相容:乳酸鹽林格氏(Lactated Ringer's)輸注液、鹼性溶液(例如sodum thiopentone)、ketorolac trometamol、propofol乳化劑。4.本品需冷藏避光貯存。5.以小靜脈作為注射處時，應使用適當的靜脈輸注液(例如0.9% 氯化鈉靜脈輸注液)將cisatracurium注射劑洗入靜脈內。 |
| IXEN | Xenetix inj 350mg/mL, 100mL (Iobitridol) | IA;IVD;IVPUSH; | | | | | 1.無法預測的過敏反應通常發生於30分鐘內，但可能會延遲至檢查後7天內出現。2.併用Metformin病患建議造影前48小時停止Metformin使用，至造影後48小時或腎功能回復時再開始使用Metformin。 |
| IXYL2V | Xylocaine IV 2% 100mg/5mL (Lidocaine) | IVD;IVP; IVPUSH; | | | Slow IV 50~100 mg/1~2 min (一小時內最高基準給藥量300mg) | I.V. infusion: 1000 mg in 250 mL (concentration: 4 mg/mL) or 2000 mg in 250 mL (concentration: 8 mg/mL) of D5W | Usual Infusion Concentrations: Adult I.V. infusion: 1000 mg in 250 mL (concentration: 4 mg/mL) or 2000 mg in 250 mL (concentration: 8 mg/mL) of D5W 不可與鹼性藥品混合，會有沉澱析出。Usual Infusion Concentrations: Pediatric Note: Premixed solutions available I.V. infusion: 8000 mcg/mL Compatibility Stable in D5LR，D51/2NS，D5NS，D5W，LR，1/4NS，NS. |
| IYER | Yervoy inj 50mg/10mL (Ipilimumab) | IVD; | | 【D5W】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | intravenous infusion over 30 minutes | 1. 請勿搖晃藥品，靜脈輸注30 分鐘。不可用同一輸注管路同時輸注其他藥物。2. 透過具有管路內過濾器(無菌、無熱原、低蛋白質吸附率)的靜脈輸注管線投予稀釋溶液。3. 製備至輸注的間隔時間勿超過24小時。4. 併用nivolumab時，需先輸注nivolumab，接著在同一天輸注YERVOY。併用 nivolumab 和含鉑雙化療時，先輸注 nivolumab，接著在同一天輸注YERVOY 並進行含鉑雙藥化療。每次輸注應使用個別的輸注袋和過濾器。5. 以0.9%氯化鈉注射液或5%葡萄糖注射液稀釋，配製成最終濃度範圍為1mg/mL至2mg/mL。 |
| IZAVI | Zavicefta inj 2gm/0.5gm (Ceftazidime + Avibactam) | IVD; | 10 mL 注射用無菌水。(溶解後內容物體積約12mL) | 【D5W】可選 仿單建議。【L/R】可選 仿單建議。【N/S】可選 仿單建議。 | | IV infusion over 2 hours，稀釋後ceftazidime濃度必須為 8-40 mg/mL。 | 1. 調配後的溶液為淺黃色溶液，不含顆粒物質。2. 從開始調配到完成製備靜脈輸注之間所經過的時間總長度不應超過30 分鐘。3. 待藥品溶解後，以氣體釋放針插入小瓶封口以釋放內部壓力（這對於保持藥品的無菌性很重要）。4. Ceftazidime 的最終濃度必須為 8-40 mg/mL，對於 3 個月到 12 個月的兒童病人，製備20 mg/mL 濃度；對於出生（包括早產）到 < 3 個月的兒童病人，製備 10 mg/mL 濃度。5. 輸注袋:稀釋液:N/S、D5W、L/R。稀釋至Ceftazidime最終濃度為8 mg/mL，具有在2至 8°C下保存最長12小時、且隨後在不超過25°C下保存最長4小時的使用中穩定性。所有其他Ceftazidime濃度 (>8 mg/mL 至 40 mg/mL) 具有在不超過25°C下保存最長4小時的使用中穩定性。6. 輸液注射針筒:稀釋液:N/S、D5W。稀釋至Ceftazidime 最終濃度為8 mg/mL 至 40 mg/mL，在不超過 25°C 下可保持最長 6小時的使用中穩定性。 |

# 附錄十二 臺安靜脈注射藥物給藥指引

更新日期: 2026/10/19

| 藥品代碼 | 商品名 (學名) | 給藥途徑 | 乾粉稀釋液 | 輸注點滴液 | IVPUSH用法建議 | IVD用法建議 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZYV | Zyvox inj 600mg/300mL (Linezolid) | IVD; | | 【D5W】可選 。【L/R】可選 。【N/S】可選 。 | | 輸注時間建議以30至120分鐘 | 1. 靜脈投與Zyvox Inj. 時，輸注時間應為30至120分鐘。不得使用此靜脈輸注袋作一系列的聯結。添加物不得注入此輸注液中。當使用ZYVOX靜脈注射劑必須同時併用其他藥物時，應該根據每一個藥品的建議劑量和投與途徑分開投與。2. Zyvox Inj.應避光儲存於25°C以下。瓶口應緊閉以避免潮濕。輸注袋在使用前，建議應保存在鋁箔外包裝內。輸注袋應預防結冰。藥物在投與之前應用眼睛檢查是否有微粒存在。3. 注意副作用：乳酸性酸中毒、血清素症候群(併用血清素類製劑或酪胺酸食品)、週邊神經病變及視神經病變、痙攣。 |

備註：N/S = normal saline or 0.9% sodium chloride, D5W = 5% dextrose in water, L/R = lactated Ringer, D5NS = 5% dextrose in normal saline, IP = Intraperitoneal
特殊族群: 註記肝、腎功能受損、年長者需調整劑量。


參考資料：
1.藥品仿單為主要參考依據。
2. Micromedex 電子資料庫。
3. UpToDate。
4. Trissel LA ed. Handbook on Injectable drugs 16th ed. 2011。
5. Drug Information Handbook with International trade names index 24th ed. 2015。